



**UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO BIOMÉDICO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOMÉDICAS-
FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA**

Rony Magalhães Martins

**MULHERES NEGRAS: INTERSECÇÃO DE RAÇA E
GÊNERO COMO FATOR DE VULNERABILIDADE NA
SAÚDE MENTAL DA COMUNIDADE ACADÊMICA**

**Niterói/RJ
2026**

Rony Magalhães Martins

**MULHERES NEGRAS: INTERSECÇÃO DE RAÇA E GÊNERO COMO FATOR
DE VULNERABILIDADE NA SAÚDE MENTAL DA COMUNIDADE
ACADÊMICA**

Dissertação de mestrado, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Biomédicas (Fisiologia e Farmacologia) da Universidade Federal Fluminense, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ciências Biomédicas. Área de concentração: Fisiologia.

**Orientadoras: Profª Drª Letícia de Oliveira
Profª Drª Mirtes Garcia Pereira**

Coorientador: Prof Dr Orlando Fernandes Junior

Niterói/RJ
2026

M379m Martins, Rony Magalhães
 MULHERES NEGRAS: INTERSECÇÃO DE RAÇA E GÊNERO COMO FATOR DE
 VULNERABILIDADE NA SAÚDE MENTAL DA COMUNIDADE ACADÊMICA / Rony
 Magalhães Martins. - 2026.
 100 f.: il.

 Orientador: Leticia de Oliveira.
 Coorientador: Mirtes Garcia Pereira; Orlando Fernandes
 Junior.

 Dissertação (mestrado)-Universidade Federal Fluminense,
 Instituto Biomédico, Niterói, 2026.

 1. Saúde mental. 2. Raça. 3. Gênero. 4. Comunidade
 acadêmica. 5. Produção intelectual. I. Oliveira, Leticia
 de, orientadora. II. Pereira, Mirtes Garcia, coorientadora.
 III. Junior, Orlando Fernandes, coorientador. IV. Universidade
 Federal Fluminense. Instituto Biomédico. V. Título.

CDD - XXX

Rony Magalhães Martins

**MULHERES NEGRAS: INTERSECÇÃO DE RAÇA E GÊNERO COMO FATOR
DE VULNERABILIDADE NA SAÚDE MENTAL DA COMUNIDADE
ACADÊMICA**

Dissertação de mestrado, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Biomédicas (Fisiologia e Farmacologia) da Universidade Federal Fluminense, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ciências Biomédicas. Área de concentração: Fisiologia.

Aprovada em: 24 de fevereiro de 2026

BANCA EXAMINADORA

Profª Drª Karin da Costa Calaza - UFF
Universidade Federal Fluminense

Profª Drª Luciana Ferrari Espindola Cabral
Centro Federal de Educação Tecnológica/RJ

Profª Drª Fátima Cristina Smith Erthal - UFRJ
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Profª. Drª. Isabel de Paula Antunes David
(Coordenadora do Programa de Pós-graduação)

*À minha família, cujo legado de esforço
moldou em mim o humano por trás
de todo futuro título.*

RESUMO

Martins, Rony Magalhães Martins. Mulheres negras: intersecção de raça e gênero como fator de vulnerabilidade na saúde mental da comunidade acadêmica. 2025. Dissertação (Mestrado em Ciências Biomédicas) - Instituto Biomédico, Universidade Federal Fluminense, Niterói.

Palavras-chave: Mulheres negras, Saúde mental, Sintomas depressivos, Comunidade acadêmica, Gênero, Raça.

O transtorno depressivo maior (TDM) afeta 5.7% da população mundial, com taxas mais elevadas entre mulheres e grupos marginalizados. A teoria da interseccionalidade de Kimberlé Crenshaw postula que sistemas de opressão, como o racismo e o sexismo, interagem para produzir formas únicas de desvantagem para indivíduos que possuem múltiplas identidades marginalizadas. Este estudo examinou os sintomas depressivos na comunidade acadêmica brasileira, com foco na intersecção entre raça e gênero, por meio de um questionário online que incluía perguntas sociodemográficas pertinentes e o Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) para avaliar sintomas de depressão em uma amostra de 3.857 participantes. Os resultados mostraram que as mulheres negras apresentaram escores de depressão mais altos (57,1% acima do ponto de corte para um diagnóstico provável de depressão) do que as mulheres brancas (45,3%), os homens negros (35,4%) e os homens brancos (32,9%). A ANCOVA confirmou efeitos significativos de gênero, raça e sua interação, com as mulheres negras apresentando as maiores médias de escores no PHQ-9. A regressão logística revelou que as mulheres negras tinham o dobro da probabilidade de atender aos critérios para um provável diagnóstico de depressão em comparação aos homens brancos. Os achados sugerem que as vulnerabilidades sistêmicas das mulheres negras, agravadas pelo racismo e sexismo, também persistem em ambientes acadêmicos. De fato, os ambientes acadêmicos apresentam barreiras estruturais, como sub-representação e estresse racializado, que podem exacerbar as disparidades em saúde mental. Este estudo destaca a necessidade urgente de políticas de saúde mental direcionadas que abordem as desigualdades interseccionais na academia, com atenção especial às experiências das mulheres negras.

ABSTRACT

Martins, Rony Magalhães Martins. **Black Women: The Intersection of Race and Gender as a Source of Mental Health Vulnerability in Academia.** 2025. Master's Thesis in Biomedical Sciences - Biomedical Institute, Federal Fluminense University, Niterói, 2025.

Keywords: Black Women, Mental health, Depressive symptoms, , Academic Community, Gender, Race.

Major depressive disorder (MDD) affects 5.7% of the global population, with higher rates among women and marginalized groups. Kimberlé Crenshaw's theory of intersectionality posits that systems of oppression, such as racism and sexism, interact to produce unique forms of disadvantage for individuals who hold multiple marginalized identities. This study examined depressive symptoms within the Brazilian academic community, with a focus on the intersection of race and gender. Data were collected via an online survey comprising sociodemographic variables and the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9). Depressive symptoms were assessed using this standardized psychometric instrument in a sample of 3,857 participants. The results showed that Black women had significantly higher depression scores (57.1% above the cut-off for a probable diagnosis of depression) than did White women (45.3%), Black men (35.4%), and White men (32.9%). ANCOVA confirmed significant effects of gender, race, and their interaction, with Black women having the highest mean PHQ-9 scores. Logistic regression revealed that Black women were twice as likely as White men to meet the criteria for a probable diagnosis of depression. The findings suggest that systemic vulnerabilities for Black women, compounded by racism and sexism, also persist in academic settings. In fact, academic settings present structural barriers, such as underrepresentation and racialized stress, that can exacerbate mental health disparities. This study highlights the urgent need for targeted mental health policies that address intersectional inequalities in academia, with particular attention to the experiences of Black women.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Fluxograma representando as etapas para obtenção da amostra final para análises estatísticas..... 36

Figura 2. Proporção de participantes com diagnóstico provável de depressão (PHQ-9 $\geq$ 9) na amostra total (44,2%) e nos quatro grupos de interseção de gênero e raça. As mulheres negras apresentaram a maior proporção acima do ponto de corte (57,1%, n = 499), seguidas pelas mulheres brancas (45,3%, n = 784), homens negros (35,4%, n = 146) e homens brancos (32,9%, n = 276)..... 40

Figura 3. Média e erro padrão da média (SEM) dos escores do PHQ-9 separados pela interseção de gênero e raça. O escore das mulheres negras foi significativamente maior do que o de todos os outros grupos ($p < 0,001$). O escore das mulheres brancas foi maior do que o dos homens, independentemente de os homens serem brancos ($p < 0,001$) ou negros ($p = 0,002$). Não houve diferença significativa entre homens brancos e negros ($p = 0,965$)..... 41

Figura 4: As mulheres pontuaram significativamente mais que os homens, utilizando o teste t de Mann-Whitney ($p < 0.001$). * = $p < 0.05$ 91

Figura 5: As pessoas que se declararam negras pontuam significativamente mais que as pessoas que se identificam como brancas, utilizando o teste t de Mann-Whitney ($p < .001$). * = $p < 0.05$91

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Características da amostra.....	39
Tabela 2. Análises post hoc que examinam a interação entre gênero e raça nas pontuações médias do PHQ-9, controlando para idade e transtornos mentais prévios.....	41
Tabela 3. Regressão logística multivariável mostrando a probabilidade de um diagnóstico provável de depressão entre diferentes grupos de intersecção de raça e gênero. Modelo multivariável controlando para idade e transtornos mentais prévios.....	42

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

COVID-19 - Coronavirus Disease 2019

OMS - Organização Mundial da Saúde

WHO - World Health Organization

OPAS - Organização Pan-Americana de Saúde

DSM-V - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fifth Edition

TDM - Transtorno Depressivo Maior

EDM - Episódio Depressivo Maior

APA - American Psychological Association

PHQ-9 - Patient Health Questionnaire-9

PNS - Pesquisa Nacional de Saúde

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

EUA - Estados Unidos da América

TMC - Transtornos Mentais Comuns

PNS-19 - Pesquisa Nacional de Saúde - 2019

DASS-21 - Depression, Anxiety and Stress Scale - 21

GHQ-12 - General Health Questionnaire - 12

OD - Odds Ratio

DASS-21 - Depression, Anxiety, and Stress Scale

STEM - Science, Technology, Engineering, and Mathematics

LABNEC - Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento

UFF - Universidade Federal Fluminense

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro

UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

CEP-UFF - Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense

CONEP - Comissão Nacional de Ética em Pesquisa

CAAE - Certificado de Apresentação de Apreciação Ética

ANCOVA - Análise de Covariância

MDD - Major depressive disorder

IHME - Institute for Health Metrics and Evaluation

DSM-IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth Edition

SPSS - Statistical Package for the Social Sciences

SEM - standard error of the mean

CI - confidence interval

UK - United Kingdom

ONS - Office for National Statistics - England and Wales

INEP - Instituto Nacional de Educação e Pesquisa

PQ - Produtividade em Pesquisa

CNPq - National Council for Scientific and Technological Development

PQ-Sr level - Produtividade em Pesquisa - Nível Sênior

ARRS - Anticipatory race-related stress

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

FAPERJ - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

IPEC - Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica

CES-D - Center for Epidemiologic Studies Depression Scale

MRGs - Microagressões raciais de gênero

WWS - White Women Syndrome

SUMÁRIO

RESUMO	vi
ABSTRACT	vii
LISTA DE ILUSTRAÇÕES	viii
LISTA DE TABELAS	ix
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS	x
SUMÁRIO	xii
1. INTRODUÇÃO	13
1.1 Transtorno Depressivo Maior (TDM)	14
1.2 Saúde mental de mulheres - Gênero como fator de vulnerabilidade	16
1.3 Saúde mental de pessoas negras - Raça como fator de vulnerabilidade	18
1.4 Saúde mental de mulheres negras - Kimberlé Crenshaw's theory of intersectionality	20
1.5 Saúde mental na comunidade acadêmica	22
1.6 Contextualização do trabalho	27
2 OBJETIVO	29
2.1. Objetivo Geral	29
2.2. Objetivos Específicos	29
3 HIPÓTESES	30
4 ARTIGO	30
5 DISCUSSÃO	59
5.1 Gênero como fator de vulnerabilidade	60
5.2 Raça como fator de vulnerabilidade	63
5.2.1 'Black-White mental health paradox'	68
5.3 A interseccionalidade gênero e raça como fator de vulnerabilidade	70
6 LIMITAÇÕES	75
7 CONCLUSÕES	76
8 REFERÊNCIAS	77
9 ANEXOS	90
9.1 Imagens e Tabelas	90
9.2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Pesquisado	91
9.3 Questionários de dados sociodemográficos	95
9.4 Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9)	98
9.5 Confirmação de submissão do artigo	99
9.6 Declaração de uso de Inteligência Artificial	100

1. INTRODUÇÃO

A saúde mental tem se caracterizado como um importante problema de saúde pública, figurando entre as principais causas de uma alta carga nos sistemas de saúde em todo o mundo (Fan et al., 2025; Hintz et al., 2023). Influenciada pela pandemia de COVID-19, a prevalência de transtornos mentais aumentou de forma acentuada após esse período (COVID-19 Mental Disorders Collaborators, 2021). Os transtornos mentais e o uso de substâncias afetam mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, estando entre as principais causas de incapacidade de trabalho (Rehm & Shield, 2019). O custo econômico associado aos transtornos mentais é estimado em aproximadamente 5 trilhões de dólares, com base nos dados do estudo *Global Burden of Disease 2019* (Arias et al., 2022).

Alterações na saúde mental interferem no desenvolvimento psicossocial, cognitivo e funcional do indivíduo, influenciando todas as áreas da vida, tais como trabalho, estudos, relacionamentos e participação comunitária (Ministério da Saúde, 2025). Com o propósito de priorizar a saúde mental no cenário global, fomentar tratamentos mais eficazes, ampliar a base de pesquisa e promover a conscientização sobre o tema, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu o *Mental Health Action Plan 2013-2030*. O documento estrutura-se em quatro objetivos centrais: (1) fortalecer a liderança e a governança em saúde mental; (2) assegurar a prestação de serviços de saúde mental e assistência social integrados e comunitários; (3) implementar estratégias de promoção e prevenção; e (4) consolidar sistemas de informação, evidências e pesquisa na área (WHO, 2023).

A população vinculada ao contexto educacional, englobando tanto a educação básica quanto a superior, foi historicamente sub-reconhecida como grupo de risco para agravos à saúde mental (Luo et al., 2024; Levecque et al., 2017). Dentre esses, o âmbito do ensino superior configura-se como um domínio particularmente negligenciado nessa discussão (Auerbach et al., 2016). Os alunos em todos os segmentos (graduandos, pós-graduandos e pós-doutorandos) possuem excesso de demandas, mudanças nos hábitos de vida e grande insegurança na vida e sobre o futuro, fatores que, em conjunto, são capazes de comprometer seriamente o seu bem-estar psicológico (Luo et al., 2024; Schofield et al., 2016). Os

profissionais da comunidade acadêmica, incluindo docentes e técnico-administrativos, também estão sujeitos a exigências elevadas, tais como sobrecarga de trabalho, pressão por produtividade acadêmica e, em muitos casos, um ambiente de trabalho hostil, fatores que igualmente podem prejudicar sua saúde mental (Diehl & Marin, 2016; Boas & Morin, 2014). Contudo, a literatura indica que os níveis de sofrimento ou comprometimento psicológico observados nesse grupo tendem a ser menos acentuados quando comparados aos relatados entre os discentes (Nudelman et al., 2026; Lana et al. 2026; Luo et al., 2024; Meeks et al., 2021; Mirón et al., 2019).

O principal objetivo deste trabalho foi analisar os sintomas de depressão na comunidade universitária, a partir de um recorte interseccional de gênero e raça, visando avaliar se, no contexto acadêmico, mulheres negras apresentam maior vulnerabilidade. A seguir, apresenta-se uma breve revisão da literatura sobre essa temática.

1.1. Transtorno depressivo maior (Depressão)

Os transtornos depressivos e de ansiedade são os distúrbios de saúde mental com maior prevalência na população mundial, afetando 5,7% da população, aproximadamente 332 milhões de pessoas (OPAS, 2025; WHO, 2025; Hintz et al., 2023). Além de sua elevada prevalência, esse quadro pode acarretar prejuízos significativos à vida do indivíduo, interferindo em suas atividades cotidianas, laborais, no sono, nos estudos e mesmo em momentos de lazer. Tais interferências repercutem de forma mais ampla, afetando negativamente tanto o núcleo familiar quanto a sociedade na qual o indivíduo está inserido (OPAS, 2025; WHO, 2025).

De acordo com a 5ª edição do Manual diagnóstico e Estatístico de transtornos mentais (DSM-5), o transtorno depressivo maior (TDM) pode ser manifestado em um episódio único ou recorrente. O episódio depressivo maior (EDM) precisa apresentar cinco ou mais dos seguintes sintomas:

- (1) humor deprimido
- (2) perda de interesse/prazer
- (3) alteração significativa de peso ou apetite (perda ou ganho)

- (4) insônia ou hipersonia
- (5) agitação ou lentificação psicomotora
- (6) fadiga ou perda de energia
- (7) sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva
- (8) dificuldade de concentração
- (9) pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida ou tentativa de suicídio.

Para a caracterização de um EDM, é necessário que os sintomas se manifestem quase diariamente por um período mínimo de duas semanas. Adicionalmente, é obrigatória a presença de pelo menos um dos seguintes sintomas centrais: (1) humor deprimido e/ou (2) perda de interesse/prazer. Por fim, tais sintomas devem causar sofrimento ou prejuízo clinicamente significativo e não podem ser atribuídos aos efeitos fisiológicos de uma substância ou a outra condição médica (APA, 2013).

Apesar da existência de tratamentos farmacológicos para esse transtorno, cerca de metade dos casos de depressão na atenção primária não são reconhecidos, devido à falta de treinamento dos médicos, limitações de tempo e à negação ou somatização dos sintomas pelos pacientes (Cepoiu et al., 2007; Duric et al., 2019). Médicos de família em diversos países relatam que o tempo curto de consulta e a relutância dos pacientes em discutir sintomas depressivos são grandes obstáculos diagnósticos (Goldman et al., 1999; Duric et al., 2019). O estigma continua sendo uma razão importante para que pacientes evitem o diagnóstico ou o tratamento, especialmente em comunidades culturais ou religiosas específicas (Bryant et al., 2013).

O contexto da pandemia de *COVID-19* acabou por representar um possível fator de estresse, capaz de elevar as prevalências de doenças relacionadas à saúde mental em toda a população mundial, especialmente para aqueles grupos que já eram mais vulneráveis (WHO, 2022). De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2022), a pandemia de *COVID-19* foi responsável por um aumento de 25% na prevalência global de ansiedade e depressão. Essa estimativa foi obtida por meio de pesquisas encomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS),

que incluíram uma revisão abrangente de revisões sistemáticas e meta-análises. No Brasil, Musse et al (2022), realizou um estudo transversal exploratório envolvendo 1.057 participantes brasileiros, no qual foi aplicado o Patient Health Questionnaire 9 - PHQ-9 (Questionário sobre a saúde do paciente - 9) como instrumento psicométrico para a avaliação de sintomatologia de depressão. Como resultado o autor encontrou um total de 53% da sua amostra pontuando para uma alta sintomatologia de depressão.

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) mostrou que 10,2% da população brasileira com 18 anos ou mais havia sido diagnosticada com depressão (IBGE, 2021). Porém, alguns grupos possuem uma maior vulnerabilidade a um possível diagnóstico, entre eles, estudantes universitários (Levecque et al., 2017; Luo et al., 2024), mulheres (APA, 2013; Alzueta et al., 2020; Salk, Hyde & Abramson, 2017; Otten, 2021), pessoas negras (Caldeira et al., 2025; Chor & Lima, 2005; Smolen & Araújo, 2017) e pessoas situadas na intersecção entre gênero e raça, ou seja, mulheres negras (Crenshaw, 1989; Erving et al., 2024; Jones et al., 2021). Desigualdades raciais e econômicas também limitam o acesso aos cuidados e tratamentos de transtornos de saúde mental, resultando em maior mortalidade e menores taxas de tratamento entre brasileiros negros e pardos (Hintz et al., 2023).

1.2. Saúde mental de mulheres - Gênero como fator de vulnerabilidade

O gênero se apresenta consistentemente como um fator relevante para a possibilidade de apresentar algum transtorno de saúde mental (Alzueta et al., 2020; APA, 2013; Baños & Miragall, 2024; Kiely, Brady & Byles, 2019; Otten, 2021). As mulheres possuem maiores taxas entre os transtornos mentais mais comuns, como ansiedade e depressão, enquanto os homens possuem uma maior chance de uso abusivo de substâncias e de comportamentos suicidas (Baños & Miragall, 2024; Kiely, Brady & Byles, 2019; Otten, 2021). Pessoas transgênero e/ou que não se identificam de forma binária possuem maiores taxas de depressão e suicidabilidade (incluindo ideação, plano e/ou tentativa), violência (associada a trauma, vitimização e/ou abuso sexual infantil) e uso de substâncias (incluindo cigarro, álcool e drogas ilícitas) do que seus pares cisgênero pertencentes a alguma minoria sexual (Newcomb et al., 2020).

Especificamente em relação a depressão, as mulheres apresentam uma prevalência aproximadamente duas vezes maior do que a dos homens (Kuehner, 2017; Salk, Hyde & Abramson, 2017). Salk, Hyde & Abramson (2017) realizaram duas meta-análises distintas: uma baseada em diagnósticos clínicos de depressão, obtidos por meio de avaliações especializadas (65 estudos), e outra baseada em sintomas depressivos mensurados por escalas psicométricas de rastreamento (screening), que indicam provável depressão, mas não configuram diagnóstico médico formal (95 estudos), representando informações de 1.716.195 e 1.922.064 pessoas em mais de 90 países. Os achados indicaram que as mulheres apresentam 95% mais probabilidade de diagnóstico de depressão e 64% mais probabilidade de apresentar sintomas depressivos quando comparadas aos homens. Além disso, o estudo concluiu que a diferença de gênero nos diagnósticos de depressão surgiu mais cedo do que se pensava, aos 12 anos. Em ambas as meta-análises, a diferença entre os gêneros atingiu seu pico na adolescência, aos 16 anos (Salk, Hyde & Abramson, 2017).

A diferença de gênero no diagnóstico de depressão ocorre em todos os países, mas varia em magnitude, sendo influenciada por fatores como status socioeconômico, equidade de gênero e normas culturais (Salk, Hyde & Abramson, 2017; Arias-de la Torre et al., 2021). Estudos realizados em populações brasileiras mostram, de forma consistente, que as mulheres apresentam maior prevalência de depressão quando comparadas aos homens (Barcelos-Ferreira et al., 2010; Silva et al., 2014; Rocha et al., 2025). Silva et al. (2014) realizaram uma meta-análise com 27 estudos, os quais avaliaram a prevalência de sintomas depressivos em 464.734 indivíduos brasileiros. A prevalência geral de sintomas depressivos em toda a população pesquisada foi de 14%, sendo duas vezes maior em mulheres do que em homens para sintomas depressivos e três vezes maior para a prevalência de transtorno depressivo maior nos últimos 12 meses (Silva et al., 2014).

No trabalho de Rocha et al. (2025), foi realizada uma extensa pesquisa sobre a saúde mental na comunidade acadêmica pela lente de gênero e parentalidade. Com uma amostra de 3.857 participantes brasileiros, foi encontrado uma diferença significativa nos sintomas de depressão entre homens e mulheres. Em relação a parentalidade, os pais apresentaram uma mediana de 4 pontos no PHQ-9, enquanto

as mães tiveram mediana de 8 pontos. Também foi observado uma proporção maior de mães (35,3%) com pontuação acima do ponto de corte (9 pontos ou mais), em comparação aos pais (23,0%). Estes resultados sugerem uma maior vulnerabilidade à depressão entre as mães (Rocha et al., 2025). Modelos de regressão logística apontaram que não houve associação significativa entre parentalidade e depressão para os homens. No entanto, para as mulheres, a parentalidade aumentou as chances de um provável diagnóstico de depressão em 1,29 vezes após ajuste para idade e presença de um diagnóstico psiquiátrico prévio. As chances de um provável diagnóstico de depressão foram maiores para mães negras, mães que tinham filhos com deficiência, mães que eram as principais cuidadoras e mães que não tinham uma rede de apoio (Rocha et al., 2025). Gênero e parentalidade também foram associados à menor capacidade de submeter manuscritos e cumprir prazos durante o período da pandemia, de modo que mulheres mães tiveram um impacto acadêmico maior, em relação aos homens com filhos (Staniscuaski et al., 2021).

No ambiente acadêmico, as mulheres também apresentam níveis mais elevados de estresse, ansiedade e sofrimento psicológico do que os homens, em todos os níveis da carreira acadêmica (graduação, pós-graduação e docentes) (Ali et al., 2025; Cen et al., 2025; Nudelman et al., 2026; Rocha et al., 2025; Rubach et al., 2022). As dificuldades adicionais relacionadas à carreira incluem a carga de trabalho elevada e discriminações no ambiente de trabalho (Ali et al., 2025). Nudelman et al. (2026) realizaram uma análise da saúde mental em estudantes de graduação (n=901), estudantes de pós-graduação (n=890), técnicos administrativos (n=744) e professores universitários e pesquisadores (n=1518). As mulheres pontuaram significativamente mais que os homens em todos os segmentos. Em modelos de regressão logística, as mulheres tinham 62% mais chances de pertencer ao grupo com provável diagnóstico de depressão (OR = 1,62; $p < 0,001$).

1.3. Saúde mental de pessoas negras - Raça como fator de vulnerabilidade

A relação entre raça e saúde mental ainda é insuficientemente documentada, em grande parte pela ausência de informações raciais em bancos públicos de dados e instrumentos de pesquisa, bem como pela limitada inclusão dessa variável como unidade de análise (Chor & Lima, 2005; Smolen & Araújo, 2017). Apesar dessa

escassez, pesquisas indicam que fatores sociais, como baixa renda, discriminação, racismo estrutural e estigma, estão associados a um maior sofrimento psicológico entre pessoas negras (Shim, 2021; Olfson et al., 2023).

Embora a prevalência de transtornos mentais nem sempre se reflita em taxas mais altas para pessoas negras ou grupos minoritários, esses grupos enfrentam maiores barreiras ao diagnóstico, ao tratamento e ao acesso a cuidados adequados (Barnes & Bates, 2017; Olfson et al., 2023). Nos EUA, o estudo de Barnes & Bates (2017) evidenciou o que eles chamam de “*Black–White depression paradox*”, que se refere ao fato de grandes estudos epidemiológicos revelarem que pessoas negras apresentam menor prevalência de depressão do que pessoas brancas, apesar de estarem expostas a níveis mais altos de estressores sociais, como racismo, discriminação, desigualdade econômica, piores condições de saúde física e outras formas de desvantagem estrutural. O chamado *Black–White depression paradox* não reflete necessariamente menor sofrimento psíquico em populações negras, mas resulta principalmente de processos de subdiagnóstico, barreiras estruturais de acesso, vieses clínicos e diferenças culturais na expressão e reconhecimento dos sintomas, levando a uma discrepância sistemática entre prevalência baseada em sintomas e prevalência baseada em diagnósticos médicos.

No Brasil, Caldeira et al. (2025) observaram que pessoas negras possuem 23% menos chances de ter acesso a um diagnóstico médico de depressão do que pessoas brancas, independentemente das variáveis socioeconômicas. O estudo identificou também uma desigualdade racial na prevalência de depressão baseada em sintomas versus autorreferida, com indivíduos negros apresentando maior prevalência de depressão baseada em sintomas do que por diagnósticos médicos (Caldeira et al., 2025). Os questionários utilizam as categorias de raça/etnia estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): branca, preta, parda, amarela/asiática e indígena. A terminologia adotada para “pessoas negras” está de acordo com o censo oficial brasileiro e com o IBGE, abrangendo indivíduos que se reconhecem como “pretos” e “pardos” (IBGE, 2022).

A raça também constitui um fator de vulnerabilidade em populações acadêmicas. Estudantes e professores negros relatam que a academia pode representar um ambiente hostil, levando a um estado de estresse crônico, fenômeno

conhecido como “fadiga da batalha racial” (Arday, 2018; Stoll et al., 2022). O racismo estrutural e institucional resulta em experiências de exclusão, hipervigilância, microagressões e falta de pertencimento, o que pode gerar sentimentos de isolamento e afetar negativamente a saúde mental dessa população (Arday, 2018; Stoll et al., 2022). Professores universitários negros enfrentam cargas adicionais, como a expectativa de liderar mudanças institucionais ou apoiar outros colegas negros, aumentando o desgaste emocional (Arday, 2021; Luu & Abraham, 2024).

1.4. Saúde mental de mulheres negras - Kimberlé Crenshaw's theory of intersectionality (1989)

A intersecção entre gênero e raça faz com que as mulheres negras enfrentem desafios únicos decorrentes de experiências interseccionais de racismo e sexismo (Crenshaw, 1989; Erving et al., 2024). Segundo o trabalho de Crenshaw (1989), as concepções dominantes de discriminação nos condicionam a pensar a discriminação em um único eixo. Esse modelo de eixo unidimensional invisibiliza as mulheres negras na conceitualização, identificação e remediação da discriminação racial e sexual. As mulheres negras muitas vezes são excluídas das teorias feministas e do discurso político antirracista porque ambos se baseiam em um conjunto discreto de experiências que frequentemente não refletem com precisão a interação entre raça e gênero (Crenshaw, 1989).

Esses problemas de exclusão não podem ser resolvidos simplesmente pela inclusão de mulheres negras dentro de uma estrutura analítica já estabelecida. Como a experiência interseccional é mais do que a soma de racismo e sexismo, qualquer análise que não leve a interseccionalidade em conta não pode abordar suficientemente a maneira particular pela qual as mulheres negras são subordinadas. Assim, para que a teoria feminista e o discurso político antirracista incorporem as experiências e preocupações das mulheres negras, todo o arcabouço usado como base para traduzir a “experiência das mulheres” ou a “experiência negra” em demandas políticas concretas deve ser repensado e reconfigurado (Crenshaw, 1989).

A intersecção entre esses dois fatores gera efeitos sinérgicos em desfechos de saúde mental, sendo as mulheres negras o grupo que apresenta taxas mais elevadas de depressão, ansiedade e sofrimento psicológico (Collins, 2015; Erving,

2020; Jones et al., 2021). Dessa forma, as mulheres negras constituem um grupo com risco muito elevado de desenvolver depressão, sobretudo por fatores socioculturais, como maior probabilidade de serem chefes de família solteiras, viverem em bairros mais pobres e com maior índice de criminalidade, assumirem a responsabilidade pelo cuidado de familiares e enfrentarem discriminação (Spikes et al., 2020; Taylor et al., 2024).

Fatores como a discriminação racial e a opressão interseccional também são extremamente relevantes para o possível diagnóstico de depressão nas mulheres negras (Hudson et al., 2015; Martins & Santos, 2023). Estudos indicam que a discriminação racial está significativamente associada à depressão (Hudson et al., 2015; Martins & Santos, 2023). O estudo de Hudson et al. (2015) identificou que níveis mais elevados de escolaridade estavam positivamente associados à discriminação racial, do mesmo modo em que, níveis aumentados de discriminação racial estavam positivamente relacionados à depressão. Postula-se que afro-americanos de nível socioeconômico mais alto têm maior probabilidade de trabalhar e viver em ambientes menos representativos e com maior exposição à discriminação racial em comparação com aqueles com níveis mais baixos de escolaridade e renda (Cole & Omari, 2003; Forman, 2003; Hudson et al., 2015). Sendo assim, compreende-se que a discriminação racial e a opressão interseccional de gênero e raça é capaz de afetar profundamente a saúde mental das mulheres negras.

Nos Estados Unidos, a Pesquisa Nacional de Vida Americana (*National Survey of American Life*) mostrou que 21,3% das mulheres negras relataram depressão, em comparação com 10,1% das mulheres brancas (Weaver et al., 2015). Estudos que focam em mulheres negras e na percepção relatada sobre sintomas de depressão identificaram 43% das mulheres negras com alta sintomatologia depressiva (Martin et al., 2024). Além das maiores taxas de diagnóstico, as mulheres negras têm menor probabilidade de receber tratamento de saúde mental em comparação com mulheres brancas, apesar de apresentarem carga semelhante ou maior de sintomas (Brown-Iannuzzi et al., 2014).

No Brasil, o estudo de Smolen et al. (2018) identificou que a prevalência de Transtornos Mentais Comuns (TMC) entre as mulheres negras é mais de três vezes superior à observada entre homens brancos. Após o ajuste por covariáveis

relevantes, a razão de prevalência entre mulheres negras permaneceu quase duas vezes e meia superior à observada entre homens brancos. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde - 2019 (PNS-19), com um total de 87.187 respondentes, mostraram que mulheres negras com baixa escolaridade foram mais de três vezes propensas a apresentar transtorno depressivo maior provável (OR = 3,11) do que homens brancos com alta escolaridade (Constante et al., 2022). Mulheres negras também foram as que menos tiveram acesso às diferentes etapas do diagnóstico de depressão, incluindo diagnóstico, acompanhamento médico regular e acesso a tratamento especializado. Os dados sugerem que, embora as mulheres negras constituam o grupo com maior necessidade de cuidados relacionados à depressão, as dificuldades de acesso ao tratamento perpetuam um sistema de opressão que invisibiliza essas mulheres (Constante et al., 2022).

1.5. Saúde mental na comunidade acadêmica

O ambiente acadêmico se mostra consistentemente como um fator de vulnerabilidade para a saúde mental. Regehr et al. (2013), em uma revisão sobre ações universitárias voltadas ao cuidado da saúde mental, salientam que este tem se configurado como um problema de grandes proporções. Os autores apontam que aproximadamente metade dos estudantes de graduação apresenta níveis que variam de leves a moderados de sintomatologia psicológica, incluindo a depressão. Em todos os níveis da carreira acadêmica, observam-se altos índices de sintomas depressivos e sofrimento mental: estudantes de graduação (Luo et al., 2024; Schofield et al., 2016; Meeks et al., 2021), estudantes de pós-graduação (Levecque et al., 2017), docentes e trabalhadores universitários (Halat et al., 2023; Meeks et al., 2021).

Em um estudo com 1.617 universitários, realizado na Turquia, Bayram e Bilgel (2008) buscaram investigar a prevalência de transtornos mentais na população acadêmica e comparar os achados com dados internacionais. A amostra, composta majoritariamente (54%) por discentes dos dois primeiros anos, era autorrelatada como sem diagnóstico psiquiátrico prévio. Contudo, a aplicação da *Depression, Anxiety and Stress Scale - 21 Items (DASS-21)*, instrumento que avalia sintomas de estresse, ansiedade e depressão, revelou que 49% da amostra apresentou algum

nível de sintomatologia depressiva. A gravidade dos sintomas foi distribuída como: leve (21,2%), moderada (19%), severa (6,1%) e muito severa (2%). Resultados convergentes foram obtidos por Mirón et al. (2019) em um estudo espanhol com 4.564 graduandos, no qual a aplicação do *Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9)* indicou que 47,2% da amostra pontuou para depressão de nível moderado ou severo.

Estudantes de graduação compartilham de fatores de risco associados a uma maior prevalência de sintomas depressivos, como pressão acadêmica, preocupações financeiras, orientação/mentoria inadequada, falta de apoio social e solidão (Luo et al., 2024; Schofield et al., 2016). A prevalência de depressão em amostras universitárias varia de acordo com o país e o método de avaliação utilizado. O estudo de Luo et al. (2024), realizado na China utilizando o PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9), encontrou uma prevalência relativamente alta de depressão entre os estudantes universitários, 48,9%. O estudo também identificou uma correlação entre o aumento da pressão acadêmica e os anos finais da graduação, sugerindo que estudantes nesses períodos apresentam maior vulnerabilidade ao desenvolvimento de sintomas depressivos.

No Brasil, Schuch et al. (2023) avaliaram a saúde mental de uma comunidade universitária no Sul do país. A depressão foi avaliada por meio do Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), e a ansiedade, pelo Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7). As prevalências de depressão e ansiedade observadas foram de 39,2% (IC95%: 37,3–41,1) e 52,5% (IC95%: 50,6–54,4), respectivamente. Com base no algoritmo proposto por Kroenke et al. (2001), a prevalência de depressão foi maior entre estudantes de graduação (49,1%), seguida por estudantes de pós-graduação (38,7%), técnicos administrativos (15,5%) e docentes (14,7%). Ainda no contexto brasileiro, um estudo conduzido com 574 graduandos da Universidade do Triângulo Mineiro também empregou o *PHQ-9* para rastrear sintomas depressivos. Em consonância com os achados internacionais, a pesquisa identificou uma alta prevalência da sintomatologia: 22,9% dos participantes apresentaram sintomas leves, 12,1%, moderados e 3,7%, graves. Adicionalmente, o estudo investigou a solidão percebida, verificando uma correlação positiva entre este construto e escores mais elevados na escala de depressão (Barroso et al., 2019).

Entre os estudantes de pós-graduação, há fatores de risco semelhantes aos

alunos de graduação. Fatores adicionais, como preocupações com a organização da pesquisa acadêmica, aumento da carga de trabalho e a intensificação no ritmo das transformações, também podem afetar a saúde mental dessa população (Levecque et al., 2017; Shen, 2015). Um estudo que utilizou o GHQ-12 (General Health Questionnaire-12) para mensurar 12 sintomas de saúde mental encontrou uma prevalência de 32% dos estudantes de doutorado com risco de ter ou desenvolver um transtorno psiquiátrico comum, especialmente depressão (Levecque et al., 2017). Para o sofrimento psicológico, a prevalência foi cerca de duas vezes maior entre os estudantes de pós-graduação, em comparação com a população geral altamente educada (OR = 1,90). Para o risco de transtorno psiquiátrico comum, a prevalência foi cerca de duas vezes e meia maior entre os estudantes de pós-graduação, em comparação com a população geral altamente educada (OR = 2,43) (Levecque et al., 2017).

De fato, o ambiente da pós-graduação é desafiador e pode ser propício para o aparecimento de transtornos mentais (Levecque et al., 2017; Shen, 2015). Evans et al. (2018) investigaram a saúde mental de 2.279 estudantes de pós-graduação provenientes de 26 países. No estudo, os autores utilizaram o *PHQ-9* para avaliar sintomatologia depressiva. Os resultados indicaram que os pós-graduandos apresentam uma probabilidade seis vezes maior de desenvolver depressão e ansiedade em comparação com a população em geral. Adicionalmente, foi observado que 39% da amostra apresentava sintomas de depressão de moderados a graves.

No Brasil, Barros et al. (2021) investigaram, por meio da Escala de Depressão de Baptista, a prevalência de sintomatologia depressiva em pós-graduandos de universidades públicas e privadas. A pesquisa contou com a participação de 2.115 mestrandos e doutorandos, dos quais 31% apresentaram sintomas de depressão moderada a grave, com maiores índices observados entre mulheres e mestrandos.

Os docentes universitários e o corpo administrativo também enfrentam uma grande carga de trabalho, expectativas intensas, busca pela excelência no ensino e responsabilidades administrativas (Halat et al., 2023). A pressão durante a carreira acadêmica e o processo de consolidação profissional em um ambiente altamente competitivo podem impactar significativamente o bem-estar mental desses profissionais (Halat et al., 2023). Segundo o estudo de Meeks et al. (2021), a

prevalência de sintomas de depressão severos em docentes e estudantes foi semelhante, sendo 31,3% para estudantes e 28,3% para docentes/funcionários. O estudo utilizou os valores recomendados para a *Depression, Anxiety, and Stress Scale* (DASS-21), instrumento psicométrico para avaliar a gravidade de sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Um estudo transversal realizado entre 459 funcionários da *Universiti Kebangsaan Malaysia* encontrou uma prevalência parecida, de 28,7%, com 26,5% dos participantes apresentando dois ou mais transtornos mentais (Manaf et al., 2021).

No cenário brasileiro, Lima e Lima-Filho (2009) realizaram um estudo com o objetivo de analisar as relações entre o trabalho docente e o adoecimento físico e mental de professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Por meio de entrevistas e questionários aplicados a 189 voluntários, os pesquisadores identificaram que 16,8% dos participantes relataram diagnóstico de depressão. Conforme discutido por Diehl e Marin (2016), esse percentual tende a aumentar progressivamente, atribuído principalmente à sobrecarga laboral e à forma como as atividades são impostas no ambiente universitário.

Em uma investigação complementar, Borsoi (2012) analisou a intensificação do trabalho docente e suas repercussões na saúde e no modo de vida dos professores. Foram entrevistados 96 docentes efetivos (56 homens e 40 mulheres), vinculados ou não a programas de pós-graduação. Os resultados indicaram que 81,3% buscaram atendimento médico e/ou psicológico, enquanto 36% relataram piora na saúde mental, sobretudo com quadros de depressão e ansiedade. Coletivamente, esses achados nacionais constituem importantes evidências de que o processo de trabalho nas instituições universitárias públicas brasileiras interfere diretamente na saúde do docente, revelando como o excesso de demandas e exigências representa uma questão crítica a ser abordada (Borsoi, 2012).

Apesar do ambiente acadêmico se configurar como um estressor capaz de prejudicar a saúde mental, diversos estudos mostram que a escolaridade pode promover resiliência e habilidades de enfrentamento necessárias para amortecer seus efeitos negativos (Visier-Alfonso et al., 2024; Sattar et al., 2022). Pesquisas realizadas no Brasil identificaram os estudantes de graduação e pós-graduação com maiores taxas de sintomas de TEPT e sintomas de depressão, quando comparados aos professores universitários (Nudelman et al., 2026; Rocha et al., 2025; Lana et

al., 2026). No trabalho de Lana et al. (2026), a prevalência de provável diagnóstico de TEPT (Transtorno de Estresse Pós-Traumático), avaliado pelo PCL-5 (*Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5*), foi maior entre alunos de graduação (30,23%), seguidos por pós-graduandos (23,55%) e docentes universitários (13,45%), possuindo a menor prevalência.

O estudo de Nudelman et al. (2026) avaliou a sintomatologia depressiva em diferentes segmentos da comunidade acadêmica, através do PHQ-9. Como resultado, encontrou escores médios mais elevados em estudantes de graduação (Média = 12.53; SD = 7.39), seguido por pós-graduandos (média = 10.39; SD = 6.97), técnicos administrativos (média = 8.08; SD = 6.61) e professores universitários (média = 6.65; SD = 6.22). Ao considerar o ponto de corte, observou-se também uma maior proporção de participantes com provável diagnóstico de depressão entre os graduandos (64,52%; n = 551), seguidos por pós-graduandos (52,91%; n = 454), técnicos (38,58%; n = 277) e professores (29,64%; n = 423). Dessa forma, infere-se que fatores de vulnerabilidade, como a idade e a instabilidade financeira, são superados ao longo da carreira acadêmica, o que acaba por atenuar os impactos na saúde mental associados a esse ambiente.

As mulheres negras dentro da academia passam pela combinação de estressores raciais e de gênero, aumentando o desgaste mental e físico (Evanoff et al., 2020; Hall et al., 2025; Longmire-Avital & Robinson, 2017). As barreiras culturais fazem com que mulheres negras em grande sofrimento psicológico dentro da academia não se sintam prontas para buscar apoio, cedendo à pressão para incorporar o estereótipo da “mulher negra forte” (Showunmi, 2023). Um estudo de Thomas et al. (2013) cunhou o termo “*Pet to Threat*”, fenômeno que retrata a vivência das mulheres negras na academia, que são inicialmente percebidas como não ameaçadoras e obedientes no início de suas carreiras, sendo muitas vezes vistas como “*pets*”. Entretanto, à medida que avançam profissionalmente, as mulheres negras possuem maior probabilidade de serem alvo de discriminação ou *bullying* no local de trabalho, ao serem percebidas como uma ameaça pelos seus pares (Showunmi, 2023; Thomas et al., 2013).

No Brasil, diversas feministas negras já abordavam o tema da interseccionalidade, como Lélia Gonzáles, reconhecida como fundadora do pensamento feminista negro no Brasil, ao articular raça, gênero e colonialidade a

partir da experiência das mulheres negras e do conceito de amefricanidade (Gonzáles & Hasenbalg, 1982; Santos & Rossetto, 2018). Na formulação política e intelectual da interseccionalidade no Brasil, Sueli Carneiro teve um papel central ao denunciar a invisibilidade das mulheres negras tanto no feminismo hegemônico quanto no movimento negro (Dias & Castro, 2020; Carneiro, 2005). Segundo Carneiro (2005), os genocídios foram combinados com epistemicídios, dispositivos que consolidaram as hierarquias raciais e nos quais as universidades se estabeleceram.

Pelo menos no que diz respeito à diversidade humana, a ciência tem sido perversa em muitos momentos. Nós produzimos uma forma de ciência, uma forma de civilização que não foi capaz de coexistir, digamos, harmonicamente com diferentes outras civilizações produzidas pela humanidade. E, muitas vezes, reduz-se essas pessoas à condição de fonte primária de pesquisa, informantes do conhecimento, mas não reconhece a autoridade da fala dos portadores desses saberes (Carneiro, 2020).

Poucos estudos se debruçam sobre a comparação em desfechos de saúde mental a partir da intersecção de gênero e raça. Um estudo nos EUA comparou sintomas de depressão de mulheres universitárias segundo a raça. Entre as mulheres negras, 52,3% preencheram critérios para depressão, significativamente mais do que os 21,7% observados entre as mulheres brancas (Longmire-Avital & Robinson, 2017). Pesquisas em programas de pós-graduação em STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*) relatam que mulheres negras vivenciam níveis maiores de depressão, ansiedade e ideação suicida (Wilkins-Yel et al., 2022). O aumento nesses desfechos de saúde mental pode estar sendo influenciado por fatores sociais no ambiente acadêmico, como uma mentoria inadequada e a falta de apoio institucional (Salerno & Zambrana, 2024).

1.6. Contextualização do trabalho

O cenário crítico estabelecido pela exposição das mulheres negras e o prejuízo à saúde mental dessa população no ambiente acadêmico torna fundamental uma análise interseccional que compare diretamente homens e mulheres, bem como negros e brancos, e especialmente que examine a intersecção entre gênero e raça,

de forma a fornecer informações cruciais sobre a vulnerabilidade diferencial entre esses grupos no ambiente acadêmico. Tal análise tem o potencial de elucidar padrões de desvantagem cumulativa e identificar populações com maior risco de resultados adversos de saúde mental. Até onde sabemos, este estudo é o primeiro a examinar sintomas depressivos considerando simultaneamente gênero e raça em um contexto acadêmico brasileiro. Espera-se que os resultados contribuam para o desenvolvimento de políticas públicas que promovam maior apoio às mulheres na academia, com atenção especial aos desafios únicos enfrentados por mulheres negras.

Este trabalho de dissertação de mestrado faz parte da segunda etapa de um estudo denominado PSICovidA, cuja primeira etapa consistiu em investigar a saúde mental dos profissionais de saúde que atuavam na linha de frente da COVID-19. A segunda etapa do projeto PSICovidA foi direcionada à comunidade acadêmica e aos profissionais da educação. O estudo foi coordenado pela aluna de doutorado Marta Nudelman e pelas professoras Leticia de Oliveira e Mirtes Garcia Pereira do Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento (LABNEC), localizado no Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense (UFF), contando com a participação da professora Isabel David e de alunos de pós-doutorado, doutorado, mestrado e iniciação científica do LABNEC. O projeto contou também com a colaboração de especialistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Os dados foram coletados entre 10 de março de 2022 e 10 de junho de 2022, durante a pandemia de COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*), momento em que a população mundial foi exposta a diversos tipos de eventos potencialmente danosos à saúde mental, como o isolamento social, o risco potencial à saúde, insegurança econômica e a perda de emprego (Loades et al., 2020; Pierce et al., 2020; Xiong et al., 2020). Ao final do estudo, o Brasil ainda enfrentava os efeitos da pandemia de COVID-19, com um total acumulado de 32,8 milhões de casos confirmados e 673.000 mortes. Durante a última semana de coleta, foram registrados 402.000 novos casos e 1.696 novas mortes. No total, 19 milhões de doses de vacina haviam sido administradas à população brasileira (Ministério da Saúde, 2025). As

universidades já haviam retomado suas atividades, incluindo aulas presenciais, com o uso obrigatório de máscaras de proteção. Em nível nacional, as medidas de distanciamento social vinham sendo progressivamente flexibilizadas, e os setores comercial e de serviços estavam operando sob regulamentações que exigiam distanciamento físico e uso de máscaras (ANVISA, 2022).

A coleta de dados foi realizada por meio de um formulário online utilizando a metodologia de amostragem em “bola de neve” (*snowball sampling*), na qual os participantes eram incentivados a compartilhar o questionário com sua rede de contatos (Leighton et al., 2025). O estudo foi divulgado aos principais sindicatos representativos dos profissionais do ensino superior e às entidades estudantis, para que pudessem compartilhar o *link* do formulário com seus membros. A pesquisa também foi disseminada pelas redes sociais (@*projetopsicovida*) para alcançar novos participantes.

O protocolo experimental e o termo de consentimento foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense (CEP-UFF) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), sob o Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) 52739721.0.0000.5243. Todos os procedimentos foram conduzidos de acordo com os padrões éticos da Declaração de Helsinque de 1964 e suas emendas posteriores. O consentimento informado por escrito foi obtido de todos os participantes antes de sua inclusão no estudo.

2. OBJETIVO

2.1. Objetivo Geral

O objetivo deste estudo é investigar sintomas de depressão na comunidade acadêmica sob a lente da intersecção entre gênero e raça. Dessa forma, será possível comparar diretamente os diferentes grupos: Homens Brancos, Homens Negros, Mulheres Brancas e Mulheres Negras.

2.2. Objetivos Específicos

1. Investigar o efeito da raça, do gênero e de sua interação sobre os sintomas

de depressão na comunidade acadêmica, utilizando um modelo de análise de covariância (ANCOVA), com controle para idade e histórico prévio de transtornos mentais, de modo a estimar efeitos principais, efeitos de interação e diferenças ajustadas entre os grupos.

2. Investigar a associação entre gênero e raça e a probabilidade de diagnóstico de depressão, utilizando regressão logística com variável dependente dicotômica (presença versus ausência de provável depressão) controlando por idade e histórico prévio de transtornos mentais.

3. HIPÓTESES

Como hipótese central, espera-se que os efeitos de gênero e raça, e especialmente sua interação, estejam associados a maior vulnerabilidade à depressão, com mulheres negras apresentando níveis mais elevados de sintomas depressivos e maior probabilidade de diagnóstico provável em comparação aos demais grupos.

4. ARTIGO

Esta dissertação deu origem a um artigo científico submetido a periódico, permitindo que o manuscrito seja incorporado à versão final da dissertação, em conformidade com as diretrizes do Programa de Pós-Graduação. O artigo foi submetido à revista *International Journal for Equity in Health* (Springer Nature), que possui um fator de impacto de 4.1. A submissão ocorreu em 11 de novembro de 2025, o artigo está em processo de revisão iniciado em 08 de dezembro.

Black Women: The Intersection of Race and Gender as a Source of Mental Health Vulnerability in Academia

Rony Magalhães Martins ¹ (ronymagalhaes@id.uff.br) 0009-0000-1241-1673
Orlando Fernandes Junior ¹ (orlandofernandesjunior@gmail.com) 0000-0002-8665-6021
Rachel Silva Machado Lana ¹ (rachelmachado@id.uff.br) 0009-0002-7252-4447
Marta de Freitas Nudelman ¹ (martanudelman@gmail.com) 0000-0003-2872-1339
Sarah Rocha Alves ¹ (alvesrochasarah@gmail.com) 0009-0005-2321-8947

Arthur Viana Machado ^{1 3} (arthurviana92@gmail.com) 0000-0001-8824-1615
Liana Catarina Lima Portugal ⁴ (lianalportugal@gmail.com) 000-0001-5086-5721
Isabel de Paula Antunes David ¹ (isabeldavid@id.uff.br) 0000-0003-3894-8043
Fátima Cristina Smith Erthal ² (erthalfs@biof.uff.br) 0000-0001-5796-3738
Eliane Volchan ² (evolchan@biof.uff.br) 0000-0001-7788-7322
Fernanda Staniscuaski ⁵ (fernanda.staniscuaski@ufrgs.br) 0000-0003-2155-1330
Zelia Maria da Costa Ludwig ⁶ (zamadaludwig@gmail.com) 0000-0002-3101-8532
Mirtes Garcia Pereira ^{1*} (mirtes_pereira@id.uff.br) 0000-0003-4682-2
Leticia de Oliveira ^{1*} (oliveira_leticia@id.uff.br) 0000-0002-8450-2264

¹ Laboratory of Neurophysiology of Behavior, Biomedical Institute, Fluminense Federal University, Niterói, RJ, Brazil

² Institute of Biophysics Carlos Chagas Filho, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brazil

³ Laboratory of Cognitive Psychophysiology, Fluminense Federal University, Rio das Ostras, RJ, Brazil.

⁴ Department of Physiological Sciences, Rio de Janeiro State University, Rio de Janeiro, Brazil.

⁵ Department of Molecular Biology and Biotechnology, Institute of Biosciences, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brazil.

⁶ Physics Department, Juiz de Fora Federal University, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil.

Abstract

Background: Major depressive disorder (MDD) affects 3.8% of the global population, with higher rates among women and marginalized groups. Kimberlé Crenshaw's theory of intersectionality posits that systems of oppression, such as racism and sexism, interact to produce unique forms of disadvantage for individuals who hold multiple marginalized identities. This study examined depressive symptoms in Brazil's academic community, focusing on the intersection of race and gender.

Methods: Members of the Brazilian academic community completed an online survey that included sociodemographic questions (such as race and gender) and the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9). Depressive symptoms were assessed using this standardized psychometric instrument in a sample of 3,857 participants.

Results: The results showed that Black women had significantly higher depression scores (57.1% above the cut-off for a probable diagnosis of depression) than did White women (45.3%), Black men (35.4%), and White men (32.9%). ANCOVA confirmed significant effects of gender, race, and their interaction, with Black women

having the highest mean PHQ-9 scores. Logistic regression revealed that Black women were twice as likely as White men to meet the criteria for a probable diagnosis of depression. The findings suggest that systemic vulnerabilities for Black women, compounded by racism and sexism, also persist in academic settings. In fact, academic settings present structural barriers, such as underrepresentation and racialized stress, that can exacerbate mental health disparities.

Conclusion: This study highlights the urgent need for targeted mental health policies that address intersectional inequalities in academia, with particular attention to the experiences of Black women.

Keywords: Black Women, Mental health, Depressive symptoms, , Academic Community, Gender, Race,.

1. Introduction

Major depressive disorder (MDD) is currently among the leading mental health concerns worldwide. It affects an estimated 4.0% of the global population, including 5.7% of adults, 4.6% of men, 6.9% of women, and 5.9% of individuals over the age of 60 [1]. Overall, approximately 280 million people worldwide live with depression [2, 3]. Data from the Brazilian National Health Survey (PNS) [4] revealed that 10.2% of respondents aged 18 and older experienced moderate to severe depressive symptoms, affecting more than 16 million people. During a depressive episode, individuals may experience persistently low mood characterized by sadness, irritability, or emptiness, often accompanied by a loss of interest or pleasure in previously enjoyed activities. Common symptoms include poor concentration, excessive guilt or low self-worth, hopelessness about the future, suicidal thoughts, disrupted sleep, changes in appetite or weight, and low energy or fatigue [1].

Beyond its clinical manifestations, depression disproportionately affects populations depending on intersecting social determinants such as gender and race. Kimberlé Crenshaw's theory of intersectionality [5] posits that systems of oppression, such as racism and sexism, interact to produce unique forms of disadvantage for individuals who hold multiple marginalized identities. Rather than experiencing racism and sexism as separate, additive forces, Black women are subject to a compounded form of discrimination that cannot be reduced to the

sum of its parts. This framework emphasizes that analysing race and gender in isolation may obscure the unique psychosocial stressors affecting Black women, thereby supporting the hypothesis that they may exhibit increased vulnerability to depressive symptoms. Evidence from the United States provides empirical support for this perspective, as Hargrove et al. [6] found that women reported more depressive symptoms than did men within the same racial and ethnic groups, while Black and Hispanic women presented higher symptom levels than did White women and Black and Hispanic men reported more symptoms than did their White counterparts.

Additional evidence underscores the central role of racism in shaping mental health outcomes. A meta-analysis demonstrated a robust association between perceived racism and adverse mental health, with consistent links to self-reported depression and anxiety [7]. Specifically, the findings suggest that the relationships between perceived racism and self-reported depression and anxiety are highly robust, underscoring the critical role that experiences of racism may play in mental health outcomes [7]. Despite the relevance of this topic, research on the intersection of gender and race and its implications for mental health remains scarce, particularly in relation to depressive symptoms [8, 9]. In the academic context, studies that directly compare depressive symptoms between men and women and between White and Black individuals while explicitly addressing this intersection are noticeably lacking.

Within academic settings, evidence suggests that higher education can exert both protective and detrimental effects on mental health. Although higher education is generally associated with protective outcomes [10], these benefits tend to be more pronounced among specific groups, particularly individuals from socioeconomically disadvantaged backgrounds [11], and they may be undermined by experiences of racial discrimination [12]. In addition, the academic environment may reproduce both sexism and structural racism, thereby exacerbating mental health challenges among minoritized groups [13, 14]. A growing body of evidence indicates that mental health in academic settings is substantially compromised, with a high prevalence of depressive symptoms [15, 16]. Moreover, Black students underutilize mental health services and are often reluctant to seek help, associating help-seeking with negative processes [17].

In summary, in this study, we employed an explicitly intersectional approach that directly compared men and women as well as Black and White participants, which may yield critical insights into differential vulnerability across gender and racial groups within academic settings. Such an analysis has the potential to elucidate patterns of compounded disadvantage and identify populations at heightened risk for adverse mental health outcomes. To the best of our knowledge, this study is the first to examine depressive symptoms by simultaneously considering gender and race in an academic context. The findings are expected to inform the development of public policies that promote greater support for women in academia, with special attention to the unique challenges faced by Black women.

2. Materials and Methods

2.1 Study Design and Recruitment

The experimental design of this study is part of the PSICovidA project, a study developed to investigate the impact of the pandemic on the mental health of the Brazilian academic community. Data collection was conducted between March 10, 2022, and June 10, 2022.

By the conclusion of the study, Brazil was still experiencing the effects of the COVID-19 pandemic, with an accumulated total of 32.8 million confirmed cases and 673,000 deaths. During the final week of data collection, 402,000 additional cases and 1,696 new deaths were recorded. Overall, 19 million vaccine doses had been administered to the Brazilian population [18]. Universities had already resumed their activities, including in-person classes, with the mandatory use of protective face masks. Nationwide, social distancing measures had been progressively relaxed, and the commercial and service sectors were operating under regulations requiring physical distancing and the use of face masks [19].

Data were collected using the snowball methodology, where participants were encouraged to share the survey with their network of contacts [20]. The study was communicated to the main trade unions representing higher

education professionals and student unions so that they could share the link to the form with their members. The study was also disseminated through the official project website (www.psicovida.org) and social media (@projktopsicovida) to reach out to new participants.

The experimental protocol and informed consent form were approved by the Research Ethics Committee of the Fluminense Federal University (CEP-UFF) and the National Commission for Research Ethics (CONEP), under the Ethical Appreciation Certificate (CAAE) 52739721.0.0000.5243. All procedures were conducted in accordance with the ethical standards of the 1964 Declaration of Helsinki and its later amendments. Written informed consent was obtained from all participants prior to their inclusion in the study.

2.2 Participants

Initially, a total of 4,465 participants accessed the online survey. The inclusion criterion required participants to be members of the academic community from a university or research institute, such as professors/faculty members, administrative staff, graduate students, or undergraduate students. The exclusion criteria included individuals who were not part of the academic community from a university or research institute ($n = 373$) and those with duplicate responses ($n = 39$). For the statistical analysis of gender and race, individuals who did not disclose their race or gender ($n = 45$) and those belonging to groups with low sample representation (Asian, Indigenous, and non-binary) ($n = 151$) were not included. Although groups with small sample sizes were not included in the statistical analyses, their descriptive data are presented in Table 1. The final sample consisted of 3,857 participants. Figure 1 provides a flowchart detailing the steps taken to obtain the final sample.

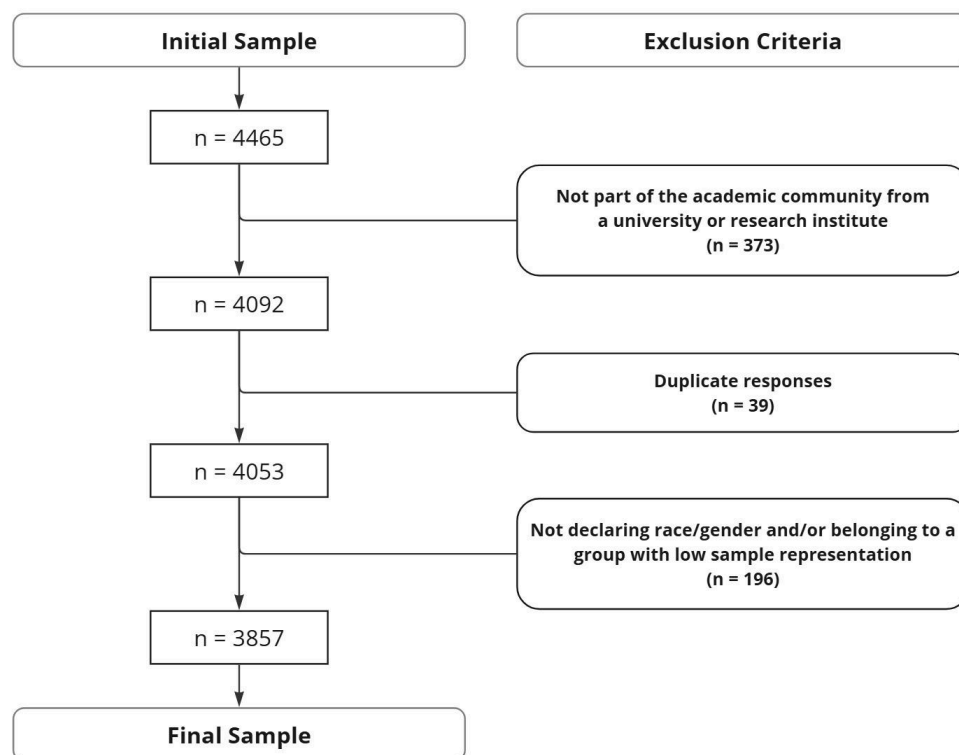


Figure 1. Flow diagram representing the steps to achieve the final sample for statistical analyses.

2.3 Psychometric Instruments

2.3.1 Sociodemographic Questionnaire

This instrument was specifically created for this research, with questions regarding gender, age, race, academic position and prior mental disorders. The classification of race follows the official Brazilian census and the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). The questionnaire used the following categories: White, Black (dark-skin Black people), Brown (light-skin Black people), Asian, and Indigenous. The study aimed to understand mental health vulnerability among men and women as well as White and Black individuals. Therefore, Black and Brown participants were grouped into the “Black” category for statistical analysis, in line with the IBGE’s understanding [21] and theories that consider both groups as victims of social marginalization and racism [22]. The participants were also invited to answer a question regarding any previous diagnosis of a mental disorder.

2.3.2 Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) [23, 24]

PHQ-9 scale data were used to assess the likelihood of a depression diagnosis according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-V). The PHQ-9 consists of nine questions addressing major depressive symptoms, as defined in the DSM-IV, and it also evaluates symptom severity through a Likert-type scale, yielding total scores between 0 and 27 points. Each question refers to the frequency of symptoms experienced over the previous two weeks and is scored from 0 (“not at all”) to 3 (“nearly every day”) [23].

The PHQ-9 scale was validated for a Brazilian population sample [24]. Following the recommendation of Santos et al. [24], we used a cut-off score of 9 or higher in the sum of the responses to indicate high levels of depressive symptomatology in the Brazilian population, representing a probable diagnosis of depression. The Cronbach’s alpha for the PHQ-9 scale in this study was 0.916.

2.4 Procedures

The participants in this study accessed the web survey by clicking on a provided link, which directed them to the Google Forms platform hosting the research instrument and directions. Initially, a brief introduction outlined the overall objectives of the study and asked whether the respondents were part of the academic community. If the response was affirmative, the participants were directed to review the informed consent terms. Those who indicated that they were not part of the academic community were redirected to a page with information on improving mental health.

After providing consent, participants were asked to complete a sociodemographic questionnaire, followed by the PHQ-9 questionnaire, which assessed their depressive symptoms.

Participants spent approximately 20 minutes completing all the questionnaires. After submitting their responses, they were provided with supportive information on managing mental health and a list of professional contacts for psychological support.

2.5 Statistical Analysis

Descriptive statistical analyses were performed to evaluate the profile of the research participants, calculating the proportion of the sample in relation to the following variables: age, gender, race, transsexuality, prior diagnosis of mental health disorders, and probable diagnosis of depression (PHQ-9 $\geq$ 9). The characteristics of this sample are described in Table 1.

To examine the influence of gender and race on depressive symptoms, the study sample was categorized into four groups: White men, Black men, White women, and Black women. Depressive symptoms served as the dependent variable in the analysis of covariance (ANCOVA), with “gender” and “race” as the independent variables. Age and prior psychiatric disorders were incorporated as control variables in the analysis. Statistical differences among the groups were assessed using the Tukey post hoc test. Following this analysis, a logistic regression model was constructed to examine whether gender and race were associated with a probable diagnosis of depression. The participants were classified as either having or not having a probable depression diagnosis based on a cut-off score of $\geq$ 9, which served as the dependent variable in the logistic regression model. Age and prior psychiatric disorders were once again incorporated as control variables in the analysis.

Statistical analyses were conducted via SPSS 25 and Stata 12.0 software. The significance level adopted for all analyses was $p < 0.05$.

3. Results

3.1 Sample Characteristics

The final sample consisted of 3,857 participants. Regarding gender, 2,606 (67.6%) identified as female, and 1,251 (32.4%) identified as male. With respect to race, 2,571 (66.7%) identified as White, and 1,286 (33.3%) identified as Black (25.6% as Brown and 7.8% as Black). Five (0.1%) participants identified as transgender, 3,828 (99.3%) did not, and 24 (0.6%) preferred not to declare. A total of 2,506 (65.0%) participants had no

previous diagnosis of mental disorders, while 1,351 (35.0%) reported having a previous diagnosis of mental disorders (Table 1). Table 1 also presents the initial sample, which includes groups that were excluded from the statistical analysis because of small sample sizes (Asian, Indigenous, and non-binary individuals), as well as participants who declined to disclose their gender or racial identity.

Table 1. Sample characteristics.

	Initial Sample (n = 4053) n (%)	PHQ-9 Score Mean (SD)	Final Sample (n = 3857) n (%)	PHQ-9 Score Mean (SD)
Age - years				
18–29 years	1199 (29.6%)	12.1 (7.2)	1142 (29.6%)	12.0 (7.3)
30–39 years	1129 (27.8%)	9.4 (6.9)	1091 (28.3%)	9.3 (6.9)
40–49 years	872 (21.5%)	8.1 (6.7)	825 (21.4%)	8.1 (6.6)
50–59 years	567 (14.0%)	6.0 (6.0)	531 (13.8%)	5.9 (5.9)
60 or more years	286 (7.1%)	4.5 (5.3)	268 (6.9%)	4.4 (5.3)
Gender				
Women	2693 (66.4%)	9.9 (7.2)	2606 (67.6%)	9.9 (7.2)
Men	1315 (32.5%)	7.3 (6.7)	1251 (32.4%)	7.2 (6.6)
Non-binary	26 (0.7%)	13.9 (7.4)	-	-
Did not declare gender	19 (0.4%)	11.7 (7.3)	-	-
Transgender				
No	3998 (98.6%)	9.1 (7.1)	3828 (99.3%)	9.0 (7.1)
Yes	17 (0.4%)	14.8 (5.8)	5 (0.1%)	15.8 (4.5)
Did not declare transsexuality	38 (0.9%)	9.6 (7.0)	24 (0.6%)	7.8 (7.1)
Race				
White	2598 (64.1%)	8.6 (7.0)	2571 (66.7%)	8.5 (7.0)
Brown	994 (24.5%)	9.9 (7.3)	987 (25.6%)	9.9 (7.2)
Black	300 (7.4%)	10.9 (7.4)	299 (7.8%)	10.9 (7.4)
Indigenous	10 (0.2%)	10.6 (7.4)	-	-
Asian	35 (0.9%)	6.7 (5.7)	-	-
Did not declare race	116 (2.9%)	9.8 (8.1)	-	-
Gender*race				
White men	839 (21.7%)	7.0 (6.6)	839 (21.7%)	7.0 (6.6)
Black men	415 (10.7%)	7.7 (6.7)	412 (10.7%)	7.7 (6.7)
White women	1732 (44.8%)	9.3 (7.0)	1732 (44.9%)	9.3 (7.0)
Black women	881 (2.8%)	11.3 (7.3)	874 (22.7%)	11.3 (7.3)
Academic position				
Undergraduate students	901 (22.2%)	12.6 (7.4)	854 (22.1%)	12.5 (7.4)
Graduate students	837 (20.6%)	10.4 (7.0)	858 (22.3%)	10.4 (7.0)
University teachers	1571 (38.8%)	6.7 (6.3)	1427 (37.0%)	6.7 (6.2)
Administrative staff	744 (18.4%)	8.1 (6.7)	718 (18.6%)	8.1 (6.6)
Previous mental disorders				
No	2557 (63.1%)	7.3 (6.4)	2506 (65.0%)	7.3 (6.4)
Yes	1496 (36.9%)	12.3 (7.2)	1351 (35.0%)	12.3 (7.2)

The average score on the PHQ-9 was 9.04 (SD = 7.1) across the entire sample. Using the cut-off point suggested by Santos et al. [24], with a score of 9 or higher indicating a probable diagnosis of depression, a total of 1,705 (44.2%) participants scored above the cut-off. By intersecting gender and race, four groups were analysed: White men, Black men, White women, and Black women. The average PHQ-9 scores for these groups are presented in Table 1. When a cut-off point of 9 or higher for a probable diagnosis of depression was used, 32.9% of White men, 35.4% of Black men, 45.3% of White women, and 57.1% of Black women scored above the cut-off (Figure 2).

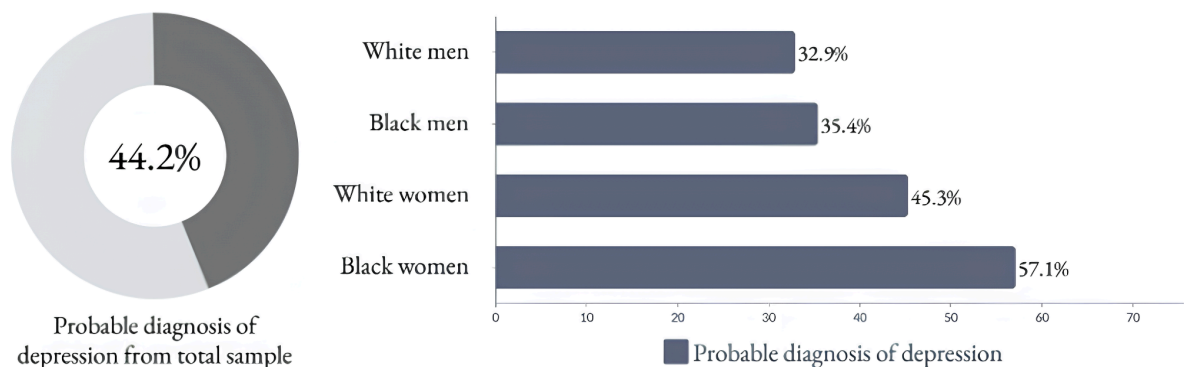


Figure 2. Proportion of participants with a probable diagnosis of depression (PHQ-9 $\geq$ 9) in the total sample (44.2%) and across the four gender–race intersection groups. Black women showed the highest proportion above the cut-off (57.1%, $n = 499$), followed by White women (45.3%, $n = 784$), Black men (35.4%, $n = 146$), and White men (32.9%, $n = 276$).

Analysis of covariance (ANCOVA) was conducted to examine the effects of gender (women and men), race (White and Black), and the interaction between these factors on depressive symptoms, with age and a prior diagnosis of a psychiatric disorder included as control variables. The results revealed a significant main effect of gender ($F(1,3853) = 72.577$, $p < 0.001$, $\eta^2 = 0.015$), race ($F(1,3853) = 9.669$, $p < 0.001$, $\eta^2 = 0.002$), and the interaction between gender and race ($F(1,3853) = 5.526$, $p = 0.019$, $\eta^2 = 0.001$), even when controlling for age and previous psychiatric diagnoses.

Post hoc analysis revealed that Black women scored significantly higher than all other groups ($p < 0.001$ for all comparisons), while White women scored significantly higher than both Black and White men ($p = 0.002$ and p

< 0.001, respectively, for each comparison). There were no significant differences between Black and White men ($p = 0.965$; Figure 3/Table 2).

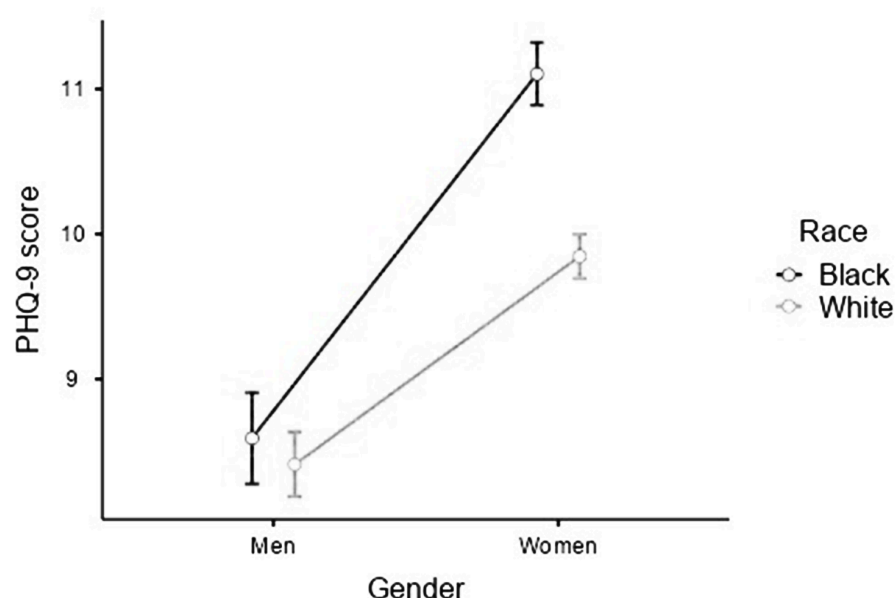


Figure 3. Mean and SEM of the PHQ-9 scores separated by the intersection of gender and race. The score of Black women was significantly greater than that of all other groups ($p < 0.001$). The score of White women was greater than that of men, regardless of whether the men are White ($p < 0.001$) or Black ($p = 0.002$). There was no significant difference between White and Black men ($p = 0.965$).

Table 2. Post hoc analyses examining the interaction between gender and race on mean PHQ-9 scores, controlling for age and prior mental disorders.

Gender*Race		Mean Difference (PHQ-9)	Standart error (SEM)	t	Tukey test P value
Black Women	White Men	2.692	0.308	8.742	<.001*
	Black Men	2.512	0.377	6.665	<.001*
	White Women	1.258	0.262	4.797	<.001*
White Women	White Men	1.434	0.265	5.406	<.001*
	Black Men	1.254	0.345	3.630	0.002*
Black Men	White Men	0.180	0.378	0.475	0.965

Model adjusted for age and previous mental disorders. * $p < 0.005$

Additionally, we conducted a multivariable logistic regression analysis to identify the likelihood of scoring above the PHQ-9 cut-off (≥ 9 , indicating a high probability of a depression diagnosis; Santos et al. 2013) among the different gender and race groups, using White men as the reference group. Age and a prior diagnosis of a psychiatric disorder were included as control variables. Black men did not differ significantly from White men in terms of the likelihood of a probable depression diagnosis ($p = 0.849$). However, White women were 1.47 times

more likely to be in the high probability of a depression diagnosis group compared to White men ($p < 0.001$), while Black women were more than twice as likely to be in the high probability of a depression diagnosis group compared to White men ($p < 0.001$; Table 3).

Table 3. Multivariable logistic regression showing the likelihood of a probable diagnosis of depression among different race and gender intersection groups. Multivariable model controlling for age and previous mental disorders.

Gender*race	Odds Ratio	z	95% CI	Wald test P value
White men	(reference)			
Black men	1.026	0.190	[-0,240-0,291]	0.849
White women	1.469	4.028	[0,198-0,572]	<.001*
Black women	2.048	6.600	[0,504-0,929]	<.001*

Multivariable model controlling for age and previous mental disorders. CI = confidence interval. * $p < 0.001$.

4. Discussion

The aim of this study was to assess the impact of the intersection between race and gender on depressive symptoms within the university community. Our results indicated that Black women exhibit significantly higher levels of depressive symptoms than do all other groups studied. In contrast, White women report fewer depressive symptoms than Black women but significantly more symptoms than either White or Black men. There was no significant difference between White and Black men in terms of depressive symptoms. With respect to potential depression diagnoses, more than half of the Black women in the study (57%) scored above the cut-off point of 9, indicating a higher likelihood of depression. Indeed, logistic regression analysis using White men as the reference group revealed that Black women were twice as likely to meet the criteria for a probable depression diagnosis compared to White men.

Taken together, these findings suggest that even within academic settings, the intersection of race and gender constitutes a set of interrelated vulnerability factors that reinforce one another, making Black women more susceptible to elevated levels of depressive symptoms. These results are consistent with Kimberlé Crenshaw's theory of intersectionality [5], which posits that overlapping systems of oppression, such as racism and sexism, create unique and compounded disadvantages. In the present study, the detection of a significant interaction

underscores the added value of assessing these intersections rather than analysing race and gender as independent variables. The substantially greater burden observed among Black women provides empirical evidence that their experience is qualitatively distinct, shaped by the simultaneous and inseparable forces of race and gender.

A growing body of research has sought to explain the greater vulnerability to mental health problems among Black women. Among the various dimensions of gendered racial microaggressions, the stereotype of the “angry Black woman” has shown the strongest association with depressive symptoms [25]. Other pervasive stereotypes can also be profoundly detrimental. For example, the “strong Black woman” schema [26] often leads to the perception that Black women do not need or deserve support [9, 27]. Furthermore, the combined effects of gendered racism and the “strong Black woman” stereotype may discourage help-seeking behaviors, thereby contributing to the higher prevalence of depressive symptoms observed in this group [28]. However, to the best of our knowledge, no study has directly compared depressive symptoms among men and women, both White and Black, within the academic community. It might be hypothesized that higher educational attainment and being in a prestigious, successful, and socially ascendant environment, such as academia, could have a protective effect on the mental health of Black women who manage to reach these spaces. However, our findings do not support this hypothesis. On the contrary, Black women remain more vulnerable to depressive symptoms despite being in an academic environment. Sue et al. [29] showed that universities themselves are sites of environmental racial microaggressions that convey exclusion, such as buildings named exclusively after White men, symbolically reinforcing the message that Black people “do not belong”. Similarly, Mowatt et al. [30] argued that Black women face a paradox of invisibility and hypervisibility: marginalized in academic recognition yet hyperexposed as racialized and gendered bodies subject to stereotyping and surveillance. This echoes the testimonies in Settles et al. [31], where Black faculty described being treated as tokens, that is, individuals who, because of their minority status, become hypervisible and subject to heightened scrutiny while simultaneously being rendered invisible through the dismissal of their contributions. These dynamics are not merely symbolic; indeed, they function as chronic psychosocial stressors that erode well-being.

Taken together, our findings support the idea that academic spaces may constitute what Settles et al. [31] describe as a “paradox of (in)visibility,” where Black women’s presence is simultaneously overexposed and undervalued. This paradox amplifies minority stress, reinforcing feelings of isolation and intensifying vulnerability to depression. By empirically demonstrating that Black women in academia are twice as likely as White men to meet the criteria for probable depression, our study extends this theoretical framework to the Brazilian context.

Historically, Black women have been underrepresented in the academic community, especially in higher education leadership positions [32, 33, 34]. Between 1997 and 2006, 85% of all vice-chancellors in the United Kingdom were men; no Black women were represented, and there was only one Black male vice-chancellor until 2011 [32, 33]. The lack of racial diversity affects all of higher education in the UK. In the 2021–2022 academic year, Black individuals represented less than 1% of senior positions, while 88% were held by White individuals [35, 36]. These figures contrast sharply with demographic trends in the general population, where the proportion of Black people has been increasing, reaching 4% in 2021 [35, 36].

In Brazil, there is a lack of data on race in the academic community. It was only in 2009, with the National Plan for the Promotion of Racial Equality, that “colour/race” was included in student data collection forms at all levels of public and private education. This information is highly relevant for the development of educational policies, which include the transfer of resources from the federal government [37]. Even with the expansion of the Black population in higher education, this growth is not reflected in career advancement, particularly in access to the highest positions of power and leadership [38]. According to data from the National Institute for Educational Studies and Research (INEP), Black students represent 38% of undergraduate students, but only 21% of university professors are Black [39].

Even in higher-prestige university positions, Black women still face significant inequality in terms of their academic careers. A study conducted by Parent in Science [40] analysed the distribution of professors’ productivity grants (PQ) in Brazil awarded by the National Council for Scientific and Technological

Development (CNPq), focusing on gender and race. The results revealed that only 5.6% of all productivity scholarships are allocated to Black women [40]. PQ grants are awarded to university professors across all fields of knowledge who stand out for their academic work, with the aim of recognizing and supporting their scientific output. The criteria for awarding these grants include scientific production, participation in the supervision of human resources, and effective contributions to the research field [41]. PQ grants have different levels, and as the grant level and value increase, the representation of Black women decreases, highlighting an effect known as the “scissors effect”. At the PQ-Sr level, the highest level possible, there are no self-declared Black people and only 6.2% self-declared Brown people [40, 42].

Over the past twenty years, affirmative action policies have facilitated Black and Indigenous students’ access to federal universities across Brazil [43, 44, 45]. The implementation of these policies appears to have significantly increased representation in highly competitive and prestigious universities. Moreover, universities that adopted strictly race-based criteria also experienced increased enrolment of students from socioeconomically disadvantaged backgrounds [46]. However, additional policies to mitigate this socioeconomic and racial inequality are still necessary. Otherwise, this underrepresentation may foster feelings of isolation and a lack of belonging, which could negatively impact their mental health. Black academics are forced to lead double lives or change their cultural codes, as the university environment does not usually understand their ethnic culture [47].

Loneliness is related to numerous personal characteristics, including low self-esteem, shyness, feelings of alienation, external locus of control, and the belief that the world is not a just place [48]. Studies show that Black women believe that to “be strong,” they must endure misery, especially in solitude, which results in feelings of disconnection from others [49]. This construction of the “strong Black woman” stereotype ultimately develops a “maladaptive perfectionism” that involves unrealistically high standards, a high perception of pressure from others, an excessive concern with mistakes, and a perceived discrepancy in relation to one’s own performance [50]. Thus, Black women who internalize the “strong Black woman” stereotype are vulnerable to mental health problems and feelings of isolation [50].

Racial discrimination indirectly predicted poorer mental health through a reduction in resilience, an important factor against depression and anxiety [51]. According to Erving et al. [52], there is a phenomenon known as anticipatory race-related stress (ARRS), which occurs when, even in the absence of racial threats or violence, racial tension is capable of inducing stress in Black individuals. Among Black university women, ARRS has been found to be positively associated with depressive symptoms [52]. In a review, Stoll et al. [53] discuss how academic pressure was a determining factor for the mental distress of Black students. Specifically, Black women reported that their academic knowledge was excessively policed and scrutinized by staff, while learning support and well-being resources were less accessible to them than they were to White individuals, which impacted Black women's mental health and learning experience [54].

Another noteworthy finding in our results is that White women exhibit higher levels of depressive symptoms than either White or Black men, with no significant difference observed between the two groups of men. These findings highlight the effect of gender in terms of vulnerability to depressive symptoms. Indeed, there is substantial converging evidence demonstrating that women are more susceptible to depression than men. Women are approximately twice as likely as men to develop depression over the course of their lives, from late adolescence to old age [55]. This gender disparity in the likelihood of developing depressive symptoms can be attributed to greater exposure to severe adversities, particularly childhood sexual abuse and other forms of violence against women and girls, as well as structural gender inequality [55]. The 2019 National Health Survey (PNS), conducted in Brazil, enabled the screening of depressive symptoms in a population-based study [56]. Using the PHQ-9, the survey revealed a higher prevalence of depressive symptoms among women (15.0%) than among men (6.1%) [57]. Our research revealed an alarmingly elevated prevalence, reaching 57.1% among Black women and 45.3% among White women, when the PHQ-9 cut-off was ≥ 9 .

This study has some limitations. First, this study was conducted during the ongoing COVID-19 pandemic. We cannot determine the extent to which our results are due to the pandemic, as we lack pre-pandemic data. However, the literature suggests that the COVID-19 pandemic exacerbated an already existing scenario of

weakened mental health [58]. Second, data were collected using a convenience snowball sampling method, which involved distributing a survey link via e-mail and WhatsApp. This approach may have restricted the scope of the study. Additionally, reliance on self-reported data may affect the accuracy and reliability of the responses, as participants could have underreported or overreported certain depressive symptoms. However, this is a common limitation in online surveys and is difficult to overcome, despite the significant contributions of studies that use this experimental approach. Finally, the classification of race was based on self-identification. It is possible that some individuals who self-identified as Black or Brown may have a phenotype that is typically associated with White individuals (or the opposite), as there was no external verification to validate self-reported race. Nevertheless, in Brazil, self-identification is widely accepted, including for accessing affirmative action policies.

In conclusion, our study suggests that even though Black women achieve high educational levels and occupy prestigious positions, they remain the most vulnerable group in terms of mental health when compared directly to White women and White and Black men. The findings highlight the urgent need for public policies and actions specifically targeting this social group that move beyond generic mental health support and adopt an intersectional perspective. Black women are underrepresented in science and academia, leading to feelings of isolation and a lack of belonging, which may contribute to mental suffering. Efforts to increase the representation of Black women in academia as actions to combat racism and harassment are crucial for creating a healthier and more inclusive academic environment for everyone.

List of abbreviations

MDD - Major depressive disorder

PHQ-9 - Patient Health Questionnaire-9

ANCOVA - Analysis of covariance

PNS - National Health Survey

WHO - World Health Organization

IHME - Institute for Health Metrics and Evaluation

IBGE - Brazilian Institute of Geography and Statistics

COVID-19 - Coronavirus Disease 2019

CEP-UFF - Research Ethics Committee of the Fluminense Federal University

CONEP - National Commission for Research Ethics

CAAE - Ethical Appreciation Certificate

DSM-V - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fifth Edition

DSM-IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth Edition

SPSS - Statistical Package for the Social Sciences

SEM - standard error of the mean

CI - confidence interval

UK - United Kingdom

ONS - Office for National Statistics - England and Wales

INEP - National Institute for Educational Studies and Research

PQ - productivity grants

CNPq - National Council for Scientific and Technological Development

PQ-Sr level - Productivity Grants Senior level

ARRS - anticipatory race-related stress

CAPES - Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel

FAPERJ - Rio de Janeiro State Research Support Foundation

Declarations

Ethics approval and consent to participate

The experimental protocol and informed consent form were approved by the Research Ethics Committee of the Fluminense Federal University (CEP-UFF) and the National Commission for Research Ethics (CONEP), under the Ethical Appreciation Certificate (CAAE) 52739721.0.0000.5243. All procedures were conducted in accordance with the ethical standards of the 1964 Declaration of Helsinki and its later amendments. Written informed consent was obtained from all participants prior to their inclusion in the study.

Consent for publication

Not applicable

Availability of data and materials

The datasets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Competing interests

The authors declare that they have no competing interests.

Funding

This work was supported in part by federal and state Brazilian research agencies Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) and Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).

Authors' contributions

Conceptualization, R.M.M, M.G.P and L.O.; methodology, R.M.M, O.F.J, R.S.M.L, M.F.N, S.R.A, A.V.M, L.C.L.P, M.G.P and L.O.; software, R.M.M.; validation, O.F.J, M.G.P and L.O.; formal analysis, R.M.M.; investigation, R.M.M.; resources, R.M.M.; data curation, R.M.M.; writing—original draft preparation, R.M.M and L.O.; writing—review and editing, R.M.M, O.F.J, R.S.M.L, M.F.N, S.R.A, A.V.M, L.C.L.P, I.P.A.D, F.C.S.E, E.V, F.S, Z.M.C.L, M.G.P and L.O.; visualization, R.M.M.; supervision, O.F.J, M.G.P and L.O.; project administration, R.M.M.; funding acquisition, M.G.P and L.O. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Acknowledgments

Not applicable

References

- [1] World Health Organization. Depressive disorder (depression). 2023. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>. Accessed 30 May 2025.
- [2] Liu Q, He H, Yang J, Feng X, Zhao F, Lyu J. Changes in the global burden of depression from 1990 to 2017: Findings from the Global Burden of Disease Study. *Journal of Psychiatric Research*. 2020;126:134–140. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2019.08.002>.

- [3] Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME). Global Health Data Exchange (GHDx). 2021. <https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/>. Accessed 30 May 2025.
- [4] Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). National Health Survey 2019: perception of health status, lifestyles, chronic diseases, and oral health: Brazil and major regions. Rio de Janeiro: IBGE; 2020. <https://www.ibge.gov.br/en/statistics/social/health/16840-national-survey-of-health.html>. Accessed 4 Jun 2025.
- [5] Crenshaw K. Demarginalizing the intersection of race and sex: a Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory, and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*. 1989;1989(1):Article 8. <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8>. Accessed 5 Jun 2025.
- [6] Hargrove TW, Halpern CT, Gaydos L, Hussey JM, Whitsel EA, Dole N, Hummer RA, Harris KM. Race/ethnicity, gender, and trajectories of depressive symptoms across early- and mid-life among the Add Health cohort. *Journal of Racial and Ethnic Health Disparities*. 2020;7(4):619–629. <https://doi.org/10.1007/s40615-019-00692-8>. Accessed 5 Jun 2025.
- [7] Pieterse AL, Todd NR, Neville HA, Carter RT. Perceived racism and mental health among Black American adults: a meta-analytic review. *Journal of Counseling Psychology*. 2012;59(1):1–9. <https://doi.org/10.1037/a0026208>. Accessed 30 Jul 2025.
- [8] Smolen JR, de Araújo EM, de Oliveira NF, de Araújo TM. Intersectionality of race, gender, and common mental disorders in Northeastern Brazil. *Ethnicity & Disease*. 2018;28(3):207–214. <https://ethndis.org/archive/files/ethndis-28-207.pdf>. Accessed 12 Oct 2025.
- [9] Abrams JA, Hill A, Maxwell M. Underneath the mask of the strong Black woman schema: disentangling influences of strength and self-silencing on depressive symptoms among U.S. Black women. *Sex Roles*. 2019;80(7):517–526. <https://doi.org/10.1007/s11199-018-0956-y>. Accessed 5 Jun 2025.

- [10] von dem Knesebeck O, Pattyn E, Bracke P. Education and depressive symptoms in 22 European countries. *International Journal of Public Health*. 2011;56(1):107–110. <https://doi.org/10.1007/s00038-010-0202-z>. Accessed 5 Jun 2025.
- [11] Bauldry S. Variation in the protective effect of higher education against depression. *Society and Mental Health*. 2015;5(2):145–161. <https://doi.org/10.1177/2156869314564399>. Accessed 12 Oct 2025.
- [12] Hudson DL, Bullard KM, Neighbors HW, Geronimus AT, Yang J, Jackson JS. Are benefits conferred with greater socioeconomic position undermined by racial discrimination among African American men? *Journal of Men's Health*. 2012;9(2):127–136. <https://doi.org/10.1016/j.jomh.2012.03.006>. Accessed 5 Jun 2025.
- [13] Qeadan F, Madden EF, Barbeau WA, Mensah NA, Azagba S, English K. Associations between discrimination and adverse mental health symptoms and disorder diagnoses among college students in the United States. *Journal of Affective Disorders*. 2022;310:249–257. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.05.026>. Accessed 12 Oct 2025.
- [14] Rocha S, Staniscuaski F, Nudelman MF, et al. The impact of parenthood on mental health within the academic community: highlighting vulnerabilities and identifying high-risk groups. *Humanities and Social Sciences Communications*. 2025;12:893. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-05178-z>. Accessed 12 Oct 2025.
- [15] Auerbach RP, Alonso J, Axinn WG, Cuijpers P, Ebert DD, Green JG, Hwang I, et al. Mental disorders among college students in the World Health Organization World Mental Health Surveys. *Psychological Medicine*. 2016. <https://doi.org/10.1017/S0033291716001665>. Accessed 5 Jun 2025.
- [16] Paiva U, Cortese S, Flor M, Moncada-Parra A, Lecumberri A, Eudave L, Magallón S, et al. Prevalence of mental disorder symptoms among university students: an umbrella review. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*. 2025;175:106244. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2025.106244>. Accessed 12 Oct 2025.

- [17] Lipson SK, Zhou S, Abelson S, Heinze J, Jirsa M, Morigney J, Patterson A, et al. Trends in college student mental health and help-seeking by race/ethnicity: findings from the Healthy Minds Study, 2013–2021. *Journal of Affective Disorders*. 2022;306:138–147. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.03.038>. Accessed 12 Oct 2025.
- [18] Ministry of Health. COVID-19 Panel: Cases and Deaths. 2025. https://infoms.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html. Accessed 12 Oct 2025.
- [19] National Health Surveillance Agency (ANVISA). Technical Note No. 55/2022/SEI/GQRIS/GGPAF/DIRE5/ANVISA. Process No. 25351.917416/2020-61. 2022. https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/copy_of_SEI_ANVISA2154924NotaTecnica.pdf. Accessed 12 Oct 2025.
- [20] Leighton K, Kardong-Edgren S, Schneidereith T, Foisy-Doll C. Using social media and snowball sampling as an alternative recruitment strategy for research. *Clinical Simulation in Nursing*. 2021;55:37–42. <https://doi.org/10.1016/j.ecns.2021.03.006>. Accessed 12 Oct 2025.
- [21] Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). Color or Race. 2022. <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca>. Accessed 13 Oct 2025.
- [22] Lopes Y. Racismo brasileiro: uma história da formação do país [Brazilian Racism: A History of the Nation's Formation]. São Paulo: Ática; 2005.
- [23] Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. *Journal of General Internal Medicine*. 2001;16(9):606–613. <https://doi.org/10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x>. Accessed 2 May 2023.
- [24] Santos IS, Tavares BF, Munhoz TN, de Almeida LSP, da Silva NTB, Tams BD, Patella AM, Matijasevich A. Sensitivity and specificity of the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) among adults from the general

population. *Cadernos de Saúde Pública*. 2013;29(8). <https://doi.org/10.1590/0102-311X00144612>. Accessed 2 May 2023.

[25] Erving CL, Williams TR, Frierson W, Derisse M. Gendered racial microaggressions, psychosocial resources, and depressive symptoms among Black women attending a historically Black university. *Society and Mental Health*. 2022;12(3):230–247. <https://doi.org/10.1177/21568693221115766>. Accessed 12 Oct 2025.

[26] Woods-Giscombé CL. Superwoman schema: African American women's views on stress, strength, and health. *Qualitative Health Research*. 2010;20(5):668–683. <https://doi.org/10.1177/1049732310361892>. Accessed 12 Oct 2025.

[27] Jones M, Womack V, Jeremie-Brink G, Dickens D. Gendered racism and mental health among young adult U.S. Black women: the moderating roles of gendered racial identity centrality and identity shifting. *Sex Roles*. 2021;85:221–231. <https://doi.org/10.1007/s11199-020-01214-1>. Accessed 12 Oct 2025.

[28] Jones MK, Leath S, Settles IH, Doty D, Conner K. Gendered racism and depression among Black women: examining the roles of social support and identity. *Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology*. 2022;28(1):39–48. <https://doi.org/10.1037/cdp0000486>. Accessed 13 Oct 2025.

[29] Sue DW, Capodilupo CM, Torino GC, Bucceri JM, Holder AMB, Nadal KL, Esquilin M. Racial microaggressions in everyday life: implications for clinical practice. *American Psychologist*. 2007;62(4):271–286. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.62.4.271>. Accessed 12 Oct 2025.

[30] Mowatt RA, French BH, Malebranche DA. Black/female/body: hypervisibility and invisibility. *Journal of Leisure Research*. 2013;45(5):644–660. <https://doi.org/10.18666/jlr-2013-v45-i5-4367>. Accessed 15 Oct 2025.

[31] Settles IH, Buchanan NT, Dotson K. Scrutinized but not recognized: (in)visibility and hypervisibility experiences of faculty of color. *Journal of Vocational Behavior*. 2019;113:62–74. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2018.06.003>. Accessed 15 Oct 2025.

- [32] Breakwell GM, Tytherleigh MY. UK university leaders at the turn of the 21st century: changing patterns in their socio-demographic characteristics. *Higher Education*. 2008;56:109–127. <https://doi.org/10.1007/s10734-007-9092-2>. Accessed 15 Oct 2025.
- [33] Burkinshaw P. Higher education, leadership and women vice chancellors: fitting in to communities of practice of masculinities. New York, NY: Springer; 2015. <https://doi.org/10.1057/9781137444042>. Accessed 15 Oct 2025.
- [34] Showunmi V. Visible, invisible: Black women in higher education. *Frontiers in Sociology*. 2023;8. Frontiers Media S.A. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.974617>. Accessed 15 Oct 2025.
- [35] Office for National Statistics (ONS). Ethnic group, England and Wales: Census 2021. 2022. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/ethnicity/bulletins/ethnicgroupenglandandwales/census2021>. Accessed 5 Jun 2025.
- [36] Xiao Y, Pinkney E, Li T, Yip PSF. Breaking the glass ceiling: unpacking female representation by gender and race in the higher education hierarchy. *Humanities and Social Sciences Communications*. 2023;10:975. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02481-5>. Accessed 12 Oct 2025.
- [37] Brazil. Decree No. 6.872 of 4 June 2009 – National Plan for the Promotion of Racial Equality. *Diário Oficial da União*. 2009. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6872.htm. Accessed 13 Oct 2025.
- [38] Sotero EC. Transformations in access to Brazilian higher education: some implications for different color and sex groups. In: Marcondes MM, Pinheiro L, Queiroz C, Querino AC, Valverde D, editors. *Black Women Dossier: Portrait of the Living Conditions of Black Women in Brazil*. Brasília: Ipea; 2013. p. 35–52. https://noticias.unb.br/images/Noticias/2016/Documentos/livro_dossie_mulheres_negras.pdf. Accessed 13 Oct 2025.

- [39] National Institute for Educational Studies and Research Anísio Teixeira (INEP). Technical summary of the 2023 Higher Education Census. Brasília: INEP; 2023. <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior>. Accessed 13 Oct 2025.
- [40] Parent in Science. Research productivity grants: an analysis by the Parent in Science Movement. Porto Alegre: Parent in Science; 2023. <https://www.parentinscience.com/documentos>. Accessed 12 Oct 2025.
- [41] Rezende LR de, Castelo Branco VTF, Savasini KV, da Luz MP, Casagrande MDT, Thives LP, Lucena LCFL, Bernucci LLB. Criteria for research productivity grants in Brazil applied to civil engineering: reflections on gender differences and the current context. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*. 2025;97(1):e20240562. <https://doi.org/10.1590/0001-3765202520240562>. Accessed 12 Oct 2025.
- [42] Silva R, Abreu ARP, Santana AE, Barbosa MCB, Nobre C. Gender and the scissors graph of Brazilian science: from equality to invisibility. *Revista Brasileira de Pós-Graduação*. 2024;18(special issue):1–14. <https://doi.org/10.21713/rbpg.v18iespecial.2011>. Accessed 12 Oct 2025.
- [43] Moraes Silva G, Toste Daflon VT, Giraut C. Seeing race as a state: verification commissions of affirmative actions in higher education in Brazil. *Política e Sociedade Latino-Americanas*. 2024;66(1):1–26. <https://doi.org/10.1017/lap.2023.18>. Accessed 15 Oct 2025.
- [44] Oliven AC. Affirmative actions, race relations, and quota policies in universities: a comparison between the United States and Brazil. *Educação*. 2007;30(1):29–51. <https://revistaseletronicas.pucrs.br/faced/article/view/539>. Accessed 15 Oct 2025.
- [45] Ferreira NT. Racial inequality and education: a statistical analysis of affirmative action policies in higher education. *EDUR • Educação em Revista*. 2020;36:e227734. <http://dx.doi.org/10.1590/0102-4698227734>. Accessed 15 Oct 2025.

- [46] Vieira RS, Arends-Kuenning M. Affirmative action in Brazilian universities: effects on the enrollment of targeted groups. *Economics of Education Review*. 2019;73:101931. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2019.101931>. Accessed 15 Oct 2025.
- [47] Sadao KC. Living in two worlds: success and the bicultural faculty of color. *Review of Higher Education: Journal of the Association for the Study of Higher Education*. 2003;26(4):397–418. <https://doi.org/10.1353/rhe.2003.0034>. Accessed 15 Oct 2025.
- [48] Russell D, Peplau LA, Cutrona CE. The revised UCLA Loneliness Scale: concurrent and discriminant validity evidence. *Journal of Personality and Social Psychology*. 1980;39(3):472–480. <https://doi.org/10.1037//0022-3514.39.3.472>. Accessed 2 May 2023.
- [49] Abrams JA, Maxwell M, Pope M, Belgrave FZ. Carrying the world with the grace of a lady and the grit of a warrior: deepening our understanding of the ‘strong Black woman’ schema. *Psychology of Women Quarterly*. 2014;38:503–518. <https://doi.org/10.1177/0361684314541418>. Accessed 12 Oct 2025.
- [50] Liao KY-H, Wei M, Yin M. The misunderstood schema of the strong Black woman: exploring its mental health consequences and coping responses among African American women. *Psychology of Women Quarterly*. 2020;44(1):84–104. <https://doi.org/10.1177/0361684319883198>. Accessed 13 Oct 2025.
- [51] Daftary A-M, Devereux P, Elliott M. Discrimination, depression, and anxiety among college women in the Trump era. *Journal of Social and Political Psychology*. 2020;8(2):765–778. <https://doi.org/10.1080/09589236.2020.176754>. Accessed 13 Oct 2025.
- [52] Erving CL, Williams TR, Holt AJ, Taylor A. Anticipatory race-related stress and depressive symptoms among U.S. Black women attending a historically Black university: are psychosocial resources stress buffers? *Sociological Inquiry*. 2025. <https://doi.org/10.1111/soin.12626>. Accessed 13 Oct 2025.

- [53] Stoll N, Yalipende Y, Byrom NC, Hatch SL, Lempp H. Mental health and mental well-being of Black students at UK universities: a review and thematic synthesis. *BMJ Open*. 2022;12:e050720. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-050720>. Accessed 13 Oct 2025.
- [54] Jackson-Cole D. Navigating toward success: Black and minority ethnic students in postgraduate science, technology, engineering and mathematics courses in England [PhD dissertation]. University of East London; 2019. https://repository.uel.ac.uk/download/0a1bf27b3ce062c7bc8fca4abf37529f82da68723e654815b29ba71b0b0ee117/2999353/2019_PhD_Jackson-Cole.pdf. Accessed 13 Oct 2025.
- [55] Kuehner C. Why is depression more common among women than among men? *The Lancet Psychiatry*. 2017;4(2):146–158. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30263-2](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30263-2). Accessed 13 Oct 2025.
- [56] Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). National Health Survey 2019: perception of health status, lifestyles, chronic diseases, and oral health: Brazil and major regions. IBGE; 2020. <https://www.ibge.gov.br/en/statistics/social/health/16840-national-survey-of-health.html>. Accessed 13 Oct 2025.
- [57] Melo APS, Bonadiman CSC, de Andrade FM, Pinheiro PC, Malta DC. Depression screening in a population-based study: Brazilian National Health Survey 2019. *Ciência & Saúde Coletiva*. 2023;28(4):1163–1174. <https://doi.org/10.1590/1413-81232023284.14912022>. Accessed 13 Oct 2025.
- [58] Weich S. Mental health after COVID-19: the risks are clear, it's now time to learn and respond. *BMJ*. 2022 Feb 16. <https://doi.org/10.1136/bmj.o326>. Accessed 13 Oct 2025.

5. DISCUSSÃO

O presente trabalho teve como objetivo investigar a sintomatologia de depressão e possível diagnóstico de depressão da população acadêmica sob a lente da intersecção entre gênero e raça, sendo possível comparar os diferentes grupos: Homens Brancos, Homens Negros, Mulheres Brancas e Mulheres Negras. Paralelamente, foi analisado o desfecho de sintomatologia de depressão da população acadêmica por gênero e raça individualmente, sendo possível comparar pessoas negras e brancas, da mesma forma em que foi possível comparar homens e mulheres.

Nossos resultados indicaram que as mulheres apresentam níveis de sintomas depressivos significativamente mais elevados em comparação aos homens (média = 9.9 e 7.2; SD = 7.2 e 6.6, respectivamente; $p < .001$; Anexos – Figura 1) e que pessoas negras apresentam níveis mais elevados em comparação às pessoas brancas (média = 10.1 e 8.5; SD = 7.3 e 7.0, respectivamente; $p = 0.002$; Anexos – Figura 2). As mulheres negras (média = 11.3; SD = 7.3) apresentam níveis significativamente mais elevados de sintomas depressivos do que todos os demais grupos estudados ($p < .001$ em todas as comparações; Artigo - Tabela 2). Em contraste, mulheres brancas (média = 9.3; SD = 7.0) relatam menos sintomas depressivos do que mulheres negras ($p < .001$; Artigo – Tabela 2), mas significativamente mais sintomas do que homens brancos (média = 7.0; SD = 6.6) ou homens negros (média = 7.7; SD = 6.7; $p < .001$ e $p = 0.002$, respectivamente; Artigo – Tabela 2). Não houve diferença significativa entre homens brancos e homens negros em termos de sintomas depressivos ($p = 0.427$). Com relação à possibilidade de diagnóstico de depressão, mais da metade das mulheres negras do estudo (57%) pontuaram acima do ponto de corte de 9, indicando maior probabilidade de depressão (Artigo – Figura 2). De fato, a análise de regressão logística, usando os homens brancos como grupo de referência, revelou que mulheres negras tinham o dobro de chances de atingir os critérios para um diagnóstico provável de depressão quando comparadas aos homens brancos.

Em conjunto, esses achados sugerem que, mesmo em ambientes acadêmicos, a intersecção entre raça e gênero constitui um conjunto de fatores de

vulnerabilidade inter-relacionados que se reforçam mutuamente, tornando as mulheres negras mais suscetíveis a níveis elevados de sintomas depressivos. Esses resultados são consistentes com a teoria da interseccionalidade de Kimberlé Crenshaw (1989), que postula que sistemas de opressão sobrepostos, como racismo e sexismo, criam desvantagens únicas e cumulativas. O fardo substancialmente maior observado entre mulheres negras fornece evidências empíricas de que sua experiência é qualitativamente distinta, moldada pelas forças simultâneas e inseparáveis de raça e gênero.

5.1 Gênero como fator de vulnerabilidade

Como relatado anteriormente, neste estudo foi possível avaliar a sintomatologia de depressão entre homens e mulheres dentro da população acadêmica, indicando maiores níveis de sintomatologia depressiva entre as mulheres em comparação aos homens (Anexos – Figura 1). Nosso resultado está de acordo com a literatura, que indica uma prevalência de depressão até duas vezes maior em mulheres, quando comparadas aos homens (Kuehner, 2017; Salk et al., 2017). Há um consenso de que a diferença de gênero na depressão possui uma etiologia multifatorial. Ademais, há um negligenciamento ao teorizar e examinar as diferenças de gênero na depressão (Hyde et al., 2008; Salk et al., 2017). Diferentes abordagens sociais enfatizam a feminização da pobreza, a violência de gênero e a desigualdade social de gênero como fatores que contribuem para as diferenças de gênero em desfechos de saúde mental, sobretudo na sintomatologia de depressão (Erving et al., 2022; Salk et al., 2017).

A teoria social-estrutural de Eagly e Wood (1999) oferece um arcabouço teórico para compreender a relação entre a magnitude das diferenças psicológicas entre homens e mulheres, a desigualdade de gênero e a divisão de gênero do trabalho (Wood & Eagly, 2012). Segundo essa teoria, a divisão sexual do trabalho em uma sociedade constitui o principal motor do comportamento diferenciado por sexo, pois sintetiza as restrições sociais sob as quais homens e mulheres conduzem suas vidas. A estrutura social acaba por fazer com que as mulheres detenham menos poder, recursos e status quando comparadas aos homens, em um fenômeno chamado de “hierarquia de gênero”, ou, como é chamado atualmente, sobretudo

pela literatura feminista, “patriarcado”. Como resultado, há a manutenção de uma baixa representação de mulheres em cargos de poder e liderança (Eagly & Wood, 1999).

Na área acadêmica, a estrutura social mantém a representação de mulheres em cargos de liderança muito baixos, ou em alguns casos, até inexistente. Esse fenômeno é retratado no trabalho de Silva et al. (2022), que descreve a falta de representatividade de mulheres em cargos de poder como “efeito tesoura”, termo originalmente cunhado por Rossiter (1995). Nas grandes áreas de ciência e tecnologia, as mulheres chegam a ser maioria nas posições iniciais da carreira (estudantes de graduação e pós-graduação), porém, ao longo da progressão da carreira, elas vão perdendo representatividade, até, enfim, não terem representação alguma nos cargos mais altos (presidência de associações e instituições de fomento à pesquisa; Silva et al., 2022).

Sendo assim, o gênero se desenha como um fator capaz de gerar persistentes desigualdades nos salários, nas oportunidades de emprego e na sobrecarga de trabalho de cuidado não remunerado, fazendo com que as mulheres possuam um risco maior de desenvolver problemas de saúde mental, quando comparadas aos homens (Erving et al., 2022). Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), as mulheres realizam a maior parte do trabalho de cuidado, seja ele remunerado ou não remunerado. Como resultado, as mulheres também acabam por enfrentar desvantagens econômicas e condições de trabalho piores, o que potencialmente prejudica o bem-estar e a saúde mental (OMS, 2024).

Dentro de toda a extensão do trabalho não remunerado, é importante ressaltar a participação feminina em duas principais dimensões: o trabalho doméstico e o cuidado infantil (Salk et al., 2017). Enquanto os homens são os principais encarregados de tarefas menos sensíveis ao tempo e possivelmente protetoras (como atividades externas ou de manutenção), as mulheres acabam por carregar uma maior carga mental associada ao trabalho doméstico e aos cuidados com os filhos, assim, uma hora de trabalho não remunerado tende a ser mais densa ou impactante para as mulheres do que para os homens (Salk et al., 2017). No Brasil, 51% das pessoas afirmam que as atividades domésticas são de responsabilidade de homens e mulheres, mas as mulheres fazem a maior parte ou são de responsabilidade apenas das mulheres (43% e 8%) (INSTITUTO CIDADES

SUSTENTÁVEIS & IPEC, 2025). Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2022 (PNAD - Contínua 2022), as mulheres gastam cerca de duas vezes mais tempo em tarefas domésticas em relação aos homens (IBGE, 2022). São 79,2% dos homens que relatam realizar tarefas domésticas, com média de 11,7 horas semanais, enquanto entre as mulheres, 91,3% relatam realizar tarefas domésticas, gastando em média 21,3 horas por semana (IBGE, 2022).

A parentalidade parece afetar diferentemente homens e mulheres até mesmo dentro da comunidade acadêmica. O estudo de Rocha et al. (2025) analisou a sintomatologia de depressão na população acadêmica pela lente de gênero e parentalidade. Os resultados mostraram que as mulheres mães apresentaram uma maior probabilidade de exibir sintomas depressivos em comparação às mulheres sem filhos, enquanto a parentalidade não apresentou efeito discernível entre os homens (Rocha et al., 2025). Análises realizadas somente com as mulheres mães identificaram fatores associados ao maior risco de depressão, como o papel principal de cuidados, ter filhos com deficiência e a ausência de uma rede de suporte social (Rocha et al., 2025). À luz desses resultados, torna-se fundamental que instrumentos sociais e de política pública substanciais, como a normalização de trabalhos domésticos e de cuidado por homens, a oferta universal de creches e a equidade de tempo durante a licenças-maternidade e paternidade, sejam adotados de forma urgente para começar a modificar essa realidade de sofrimento mental pelas mulheres, sobretudo por mães.

A violência de gênero pode constituir mais um fator crônico de adoecimento mental para as mulheres. Uma pesquisa realizada em 10 capitais brasileiras mostrou que em cada 4 mulheres, 3 relatam já ter sofrido assédio em locais públicos. No ambiente de trabalho, 38% das mulheres relatam situações de assédio (INSTITUTO CIDADES SUSTENTÁVEIS & IPEC, 2025). Em outro levantamento, o percentual de mulheres que dizem sentir medo de sofrer violência ao se deslocarem pela cidade chega a 97% (INSTITUTO LOCOMOTIVA, 2024). A violência psicológica também tem efeito sobre os desfechos depressivos, possivelmente causando uma desregulação emocional persistente e retraimento social. Esses efeitos se mantêm mesmo após o controle para outros tipos de violência (Lagdon et al., 2014).

De modo geral, compreende-se que as condições sociais marcadas pela violência, pela desigualdade estrutural e por uma lógica hierárquica de gênero, bem

como a persistente sub-representação das mulheres em cargos e posições de liderança, constituem efeitos históricos e crônicos de processos de discriminação sistemática capazes de afetar a saúde mental das mulheres (Bourdieu, 2001; Connell & Messerschmidt, 2005). Sobretudo, enfatizar a maior prevalência de depressão entre mulheres pode tornar esse transtorno um estereótipo de “transtorno feminino” (Silva et al., 2024). Esse estereótipo pode ser prejudicial para homens e mulheres, tendo em vista que os papéis de gênero impostos pela sociedade acabam por levar homens a repressar seus sentimentos e evitar a busca por ajuda psicológica, enquanto as mulheres podem sofrer um sobrediagnóstico e, potencialmente, a medicalização excessiva (Silva et al., 2024). É imprescindível que profissionais de saúde estejam atentos à identificação da depressão entre homens, uma vez que vieses de gênero nos processos diagnósticos já foram amplamente documentados (Aires et al., 2025).

Embora as evidências indiquem que os homens apresentem menor prevalência de depressão quando comparados às mulheres, reforçadas pelos resultados do nosso estudo, esse dado não deve ser interpretado como indicativo de menor sofrimento psíquico entre homens que vivenciam quadros depressivos. Pelo contrário, estudos sugerem que a depressão masculina pode se manifestar de forma distinta, frequentemente associada a maior resistência à busca por ajuda e maior risco de desfechos graves, como o suicídio (Courtenay, 2000; Oliffe et al., 2016). Assim, a subidentificação da depressão em homens pode resultar em atraso no tratamento e agravamento do quadro clínico, reforçando a necessidade de abordagens diagnósticas sensíveis às construções sociais de gênero.

5.2 Raça como fator de vulnerabilidade

Neste estudo, também foi possível avaliar a sintomatologia de depressão entre pessoas que se declararam negras (pretos e pardos) e pessoas que se declararam brancas dentro da população acadêmica, indicando maiores níveis de sintomatologia de depressão entre as pessoas negras (Anexos – Figura 2). É necessário enfatizar que dados relativos à raça ainda são altamente faltantes em bancos públicos de dados e instrumentos de pesquisa, o que dificulta a análise dessa variável, e assim, dificulta a criação de políticas públicas direcionadas a essa

população (Chor & Lima, 2005; Smolen & Araújo, 2017). Apesar da escassez desses dados, a literatura mostra que fatores sociais como baixa renda, discriminação, racismo estrutural e estigma são associados a um maior sofrimento em pessoas negras (Shim, 2021; Olfson et al., 2023). Em cenários extremos, o viés racial pode ter consequências fatais, como no caso da maior probabilidade de policiais atirarem em suspeitos negros desarmados em simulações computacionais, em comparação com suspeitos brancos desarmados (Plant & Peruche, 2005).

A sociedade foi estruturada através de um conjunto de mecanismos pelos quais, ao longo do tempo, perpetuaram-se disparidades e vieses altamente prejudiciais à população negra (Caldwell & Bledsoe, 2019). O racismo estrutural refere-se aos dispositivos capazes de produzir, fomentar e perpetuar a discriminação racial, atuando através de leis, políticas institucionais e práticas sistêmicas que desproporcionalmente prejudicam populações racializadas e etnicamente minorizadas (Caldwell & Bledsoe, 2019; Kisa & Kisa, 2025). Reforçadores de educação, emprego e saúde são alguns dos instrumentos capazes de institucionalizar a discriminação racial (Caldwell & Bledsoe, 2019; Williams et al., 2019). No Brasil, as pessoas negras só passaram a ter amplo acesso à educação básica a partir da década de 1960. Dessa forma, entende-se que a ideia e o discurso de meritocracia acabam por legitimar a exclusão do acesso à educação por estudantes negros (Henriques, 2017).

É necessário fazer uma contextualização histórica no que diz respeito às relações raciais existentes no Brasil, desde o Brasil colonial. A escravidão foi um elemento estruturante da sociedade brasileira, organizando não só a economia, como também padrões de hierarquia social e de autoridade (Carvalho, 2021). Essa relação de poder desenvolvida através do silenciamento e subalternização da população negra durou entre os anos de 1500 até 1888, quando a criação da Lei Áurea aboliu a escravidão legal no Brasil, mas fez isso sem políticas públicas de integração social, sem acesso à terra, educação, trabalho qualificado ou proteção econômica para os recém-libertos (Carvalho, 2021; Baptista, Bandeira & Souza, 2018). A transição da exploração da mão de obra escravizada para a relação de venda da força de trabalho por parte do trabalhador livre, gerou uma superpopulação relativa de seres humanos, caracterizados como desclassificados sociais, que compreendiam os pobres e pessoas escravizadas recém-libertas

não absorvidas pelo mercado e que, diante das circunstâncias, estariam fadadas ao subemprego e ao quase-assalariamento (Barbosa, 2003; Carvalho, 2021). Para além da transmutação da população negra em uma superpopulação relativa, Lélia Gonzalez (2018) enfatiza que os pretos e pardos não apenas passam a compor um exército industrial de reserva, mas uma massa marginal crescente diante da falta de acesso a atividades inseridas no mercado hegemônico.

No que se refere aos dados atuais de emprego, percebe-se uma alta representação de pessoas negras em cargos com menor remuneração. Em 2019, trabalhadores brancos ganhavam, em média, 73,9% a mais do que pretos ou pardos (IBGE, 2020). Na pesquisa “Síntese de Indicadores Sociais – Uma análise das condições da vida da população brasileira 2019”, as maiores proporções de presença de trabalhadores negros ou pardos foram registrados na Agropecuária (60,8%); Construção civil (62,6%); e Serviços Domésticos (65,1%). A renda média em cada uma dessas atividades foi de R\$ 1.300, R\$ 1.742 e R\$ 878, respectivamente em 2018 – abaixo da média nacional para aquele ano (R\$ 2.163; IBGE, 2020). Dados mais recentes do Censo 2022 mostram que apenas 8,6% dos cargos de gerência ou diretoria pertencem a pessoas negras (IBGE, 2022). Entre diretores e agentes, as pessoas negras ganham 34% menos que as pessoas brancas (IBGE, 2025; Moura, 2025). A consequência da discriminação, ocasionada pelo preconceito implícito e pelo processo escravista brasileiro, ao longo do tempo levou a estratificação social (Araújo et al, 2022). No âmbito da saúde pública, uma ampla revisão sistemática constatou que parte dos profissionais de saúde apresentam vieses implícitos capazes de impactar negativamente a prestação do cuidado. Suposições atribuídas à raça demonstraram afetar negativamente as interações entre pacientes e médicos e, em última instância, contribuir para piores desfechos em saúde (Hall et al., 2015).

Dadas as discussões em curso sobre racismo e viés racial, estudos começaram a chamar a atenção para a discussão sobre as formas sutis e encobertas de racismo e como essas “microagressões” seriam capazes de afetar a saúde mental das minorias raciais (Erving et al., 2022; Michaels et al., 2022; Okazaki, 2009; Sue et al., 2007). É importante ressaltar o papel das “microagressões” na saúde mental das pessoas negras, já que o racismo pessoal ou institucional frequentemente ocorre de forma implícita, automática e muitas vezes

sem a intenção consciente de prejudicar membros de grupos minoritários (Henkel, Dovidio & Gaertner, 2006; Okazaki, 2009). Segundo Sue et al. (2007), as microagressões são definidas como “indignidades verbais, comportamentais ou ambientais breves e cotidianas, intencionais ou não, que comunicam insultos e desqualificações raciais hostis, depreciativos ou negativos dirigidos a pessoas negras”. Como as microagressões raciais são frequentemente vistas como inocentes e inofensivas, aqueles que reagem negativamente são rotulados como excessivamente sensíveis ou paranoicos (Sue et al., 2007; Okazaki, 2009).

Sendo assim, entende-se que a discriminação racial atua como um estressor psicossocial que possui implicações negativas para a saúde mental de indivíduos negros. A forma como essas pessoas avaliam essas experiências parece ser um ponto crucial para o impacto na saúde mental, por exemplo, indivíduos que minimizam a importância da raça no contexto social são menos propensos a interpretar interações negativas como discriminação racial, do mesmo modo que aqueles que enfatizam a importância da raça ou que demonstram maior consciência das desigualdades sociais sistêmicas estão mais inclinados a atribuir experiências ambíguas de tratamento injusto à discriminação racial (Chae et al., 2017).

As pessoas negras também enfrentam o estigma racial, que funciona como uma das causas da desigualdade em saúde ao moldar o acesso a recursos e a exposição ao estresse. O estigma racial é definido como um sistema de rotulação e estereotipagem social que associa a raça a atributos negativos, resultando em perda de status e discriminação (Hatzenbuehler & Link, 2014). As pessoas negras frequentemente são vistas como emocionalmente fortes, o que leva à crença de um baixo sofrimento mental e uma baixa necessidade de ajuda ou intervenção médica (Bhui, 2018). Assim, para os indivíduos que necessitam de tratamento, a possibilidade de acessar uma terapia adequada no momento em que precisam pode ser potencialmente limitada quando os serviços são percebidos como pouco acolhedores ou negativos. A experiência de não ser ouvido, de ser desacreditado ou de ser tratado com hostilidade é comumente relatada por usuários dos serviços e revela dinâmicas implícitas de poder que atuam como um contexto para as desigualdades (Bhui, 2018).

A raça também parece representar um fator de vulnerabilidade dentro da comunidade acadêmica. Alunos negros que relatam sofrer microagressões no

ambiente acadêmico apresentaram maiores sintomas de depressão, ansiedade e estresse, mediados por pensamentos ruminativos, quando comparados aos alunos que não relataram sofrer essa forma de discriminação (Farber et al., 2021). O estigma associado à população negra forma uma consistente barreira no acesso a serviços dentro da universidade, incluindo a falta de compreensão cultural, dificuldades de comunicação e incertezas sobre onde e como buscar ajuda (Grey et al., 2013). O estudo de Stoll et al. (2022) buscou analisar, através de uma revisão bibliográfica, o impacto do pertencimento, do isolamento e da marginalização de estudantes de minorias étnicas na saúde mental dessa população. Os resultados sugeriram que esses alunos experienciam discriminação explícita e falta de acesso a serviços culturalmente apropriados, que reconheçam a condição racializada vivida por eles, sendo necessária a criação de serviços de saúde mental pensados para a população de minorias étnicas, com formatos linguísticos adequados, de modo a favorecer a compreensão sobre sua saúde mental e sobre como buscar intervenção e apoio profissional (Stoll et al., 2022).

Docentes negros e de minorias étnicas sofrem cotidianamente dentro do ambiente universitário, que possui uma grande centralidade na branquitude, reforçada por meio de práticas de hipervigilância, microagressões raciais e pela escassez de oportunidades de progressão profissional (Arday, 2021; Law, 2017). Se aventurar por esse terreno desigual pode levar esses indivíduos a uma exaustão mental, impactando subsequentemente aspectos do desempenho profissional dentro de um cenário inflexível e estruturalmente desigual. Esse paradigma é conhecido como “fadiga da batalha racial” (racial battle fatigue, em inglês) (Arday, 2021; Rollock, 2016; Smith et al., 2007). Smith et al. (2007) definem a “fadiga da batalha racial” como o resultado cumulativo de uma resposta natural ao estresse relacionado à raça diante de condições mentais e emocionais angustiantes. A ausência de mecanismos adequados para ajudar a população negra e de minorias étnicas dentro da universidade acaba por levar essa população a lidar com os problemas relacionados à saúde mental de forma individualizada, intensificando sentimentos de isolamento, marginalização e solidão (Arday, 2021; Keating, 2007).

Sendo assim, o racismo tem um papel determinante na saúde mental da população negra, moldando o acesso a recursos e as respostas institucionais (Caldwell & Bledsoe, 2019). Esses mecanismos têm impacto direto tanto na

produção do conhecimento científico quanto nas práticas clínicas, contribuindo para desigualdades persistentes nos diagnósticos, no acesso ao cuidado e nos desfechos em saúde entre grupos racializados (Bryant et al., 2022). As pessoas negras enfrentam maiores barreiras para diagnósticos, tratamento e acesso a cuidados adequados. Dessa forma, estudos frequentemente não encontram maiores taxas de depressão na população negra (Barnes & Bates, 2017; Olfson et al., 2023). Nos EUA, o estudo de Barnes & Bates (2017) evidenciou o que eles chamam de ‘Black–White mental health paradox’, definido como o fenômeno de sub-representação de diagnósticos de depressão na população negra.

5.2.1 ‘Black-White mental health paradox’

Pesquisas realizadas nos Estados Unidos descrevem um cenário em que as populações negras são mais expostas a experiências de discriminação racial, microagressões e exclusão social, fatores esses capazes de aumentar o sofrimento psicológico e, assim, os sintomas depressivos (Barnes & Bates, 2017; Schwartz & Meyer, 2010). Apesar disso, grandes estudos epidemiológicos mostram, de forma paradoxal, uma menor prevalência de diagnósticos psiquiátricos formais de depressão entre pessoas negras, em comparação às pessoas brancas. Esse fenômeno é amplamente conhecido como “Black–White mental health paradox” (Barnes & Bates, 2017; Lincoln et al., 2011).

Dados indicam que pessoas negras possuem níveis mais elevados de sofrimento psicológico inespecífico, quando comparadas às pessoas brancas (Oates & DeMaris, 2022). Embora esse conjunto de dados seja consistente com as previsões do paradigma do estresse social, era esperado que os transtornos psiquiátricos, sobretudo o diagnóstico de depressão, estivessem positivamente correlacionados com o sofrimento psicológico, já que há uma sobreposição substancial entre os sintomas utilizados para diagnosticar transtornos do humor e de ansiedade e aqueles empregados para mensurar sofrimento psicológico (Barnes & Bates, 2017; Schnittker, 2012). De fato, estudos documentam fortes associações positivas entre depressão e sofrimento psicológico na população geral. No estudo que validou o PHQ-9, associações entre o *Center for Epidemiologic Studies Depression Scale* (CES-D) e o PHQ-9 demonstraram uma forte validade de critério

para ambas as medidas, utilizadas para mensurar o sofrimento psicológico e a sintomatologia de depressão, respectivamente (Kroenke, 2001).

A revisão sistemática de Barnes & Bates (2017) mostrou uma menor prevalência de depressão em pessoas negras do que em pessoas brancas em 8 dos 9 estudos analisados, mas níveis mais elevados de sofrimento psicológico em 42 das 45 comparações. Conforme observado, os padrões de menor prevalência de depressão em pessoas negras em comparação às pessoas brancas, associados a níveis mais elevados de sofrimento psicológico, indicam um duplo paradoxo. O primeiro paradoxo refere-se ao fato de que, sob a perspectiva do paradigma do estresse social, seria esperado que a população negra apresentasse uma maior prevalência de depressão do que as pessoas brancas. O segundo paradoxo diz respeito ao sofrimento psicológico da população negra, uma vez que o sofrimento psicológico e o diagnóstico de depressão são discordantes em relação às evidências encontradas na literatura, de uma forte associação positiva entre depressão maior e sofrimento psicológico (Barnes & Bates, 2017; Schnittker, 2012).

Para explicar o primeiro paradoxo, Barnes & Bates (2017) sugerem que os métodos de mensuração e coleta utilizados em estudos epidemiológicos captam a depressão de forma mais eficaz em pessoas brancas do que em pessoas negras (Breslau et al., 2008; Uebelacker et al., 2009). Outra hipótese levantada é que as pessoas brancas têm maior probabilidade do que as pessoas negras de buscar serviços para problemas de saúde mental (Park et al., 2025). No entanto, não há evidências de uma explicação consistente em relação ao segundo paradoxo proposto.

Como explicação artefactual encontrada para ambos os paradoxos, Barnes & Bates (2017) sugerem que o diagnóstico de depressão pode levar a uma classificação diferencial incorreta entre negros e brancos. Por exemplo, a exigência da presença de humor deprimido ou anedonia, ambos considerados sintomas psicológicos da depressão, pode subestimar desproporcionalmente a depressão em pessoas negras, caso estas expressem a depressão de forma mais somática do que as pessoas brancas, conforme sugerido por alguns autores (Ayalon & Young, 2003; Barnes & Bates, 2017; Das et al., 2006). Dessa forma, estudos que buscam investigar o sofrimento psicológico são mais sensíveis ao sofrimento da população negra, ao mesmo tempo em que estudos que buscam identificar o diagnóstico de

depressão por meio de critérios diagnósticos são menos sensíveis aos sintomas relatados por pessoas negras.

O estudo de Caldeira et al. (2025), realizado no Brasil, buscou investigar a desigualdade racial na prevalência de depressão baseada em sintomas (mensurada por meio do PHQ-9) versus depressão autorreferida (diagnóstico médico por autorrelato). A população negra apresentou maior prevalência de depressão baseada em sintomas, quando comparado ao diagnóstico médico (11,0% e 8,6%, respectivamente), enquanto a população branca apresentou maior prevalência de depressão por diagnóstico médico, quando comparada à depressão baseada em sintomas (12,5% e 10,6%, respectivamente). Ainda no que se refere ao diagnóstico médico de depressão, evidenciam-se desigualdades raciais significativas. Pessoas negras que apresentam sintomas depressivos possuem 23% menor probabilidade de receber um diagnóstico médico de depressão quando comparadas às pessoas brancas, independentemente do ajuste por variáveis socioeconômicas, o que aponta para a persistência de iniquidades raciais no acesso ao reconhecimento clínico da depressão no Brasil (Caldeira et al., 2025).

5.3 A interseccionalidade gênero e raça como fator de vulnerabilidade

O nosso estudo também permitiu a realização de uma análise interseccional entre gênero e raça e o impacto dessas variáveis na sintomatologia de depressão, possibilitando a comparação direta entre Mulheres negras, Mulheres brancas, Homens negros e Homens brancos. Até onde sabemos, nosso estudo é o primeiro a realizar essa comparação dentro do ambiente universitário. As mulheres negras apresentam níveis significativamente mais elevados de sintomas depressivos do que todos os demais grupos estudados ($p < .001$ em todas as comparações; Artigo - Tabela 2). Em contraste, as mulheres brancas relatam menos sintomas depressivos do que as mulheres negras ($p < .001$; Artigo - Tabela 2), mas significativamente mais sintomas do que os homens brancos ou os homens negros ($p < .001$ e $p = 0.002$, respectivamente; Artigo - Tabela 2). Não houve diferença significativa entre os homens brancos e os homens negros em termos de sintomas depressivos ($p = 0.427$). Com relação à possibilidade de diagnóstico de depressão, mais da metade das mulheres negras do estudo (57%) pontuou acima do ponto de corte de

9, indicando maior probabilidade de depressão (Artigo - Figura 2). De fato, a análise de regressão logística usando os homens brancos como grupo de referência revelou que as mulheres negras tinham o dobro de chances de atingir os critérios para um provável diagnóstico de depressão quando comparadas aos homens brancos (Artigo - Tabela 3).

Os achados do nosso trabalho estão de acordo com a literatura sobre o tema, que mostra as mulheres negras como o grupo mais vulnerável ao sofrimento mental (Crenshaw, 1989; Erving et al., 2024a; Jones et al., 2021). Em conjunto, esses achados sugerem que, mesmo em contextos acadêmicos, a interseção entre raça e gênero constitui um conjunto de fatores de vulnerabilidade que se reforçam mutuamente, tornando as mulheres negras mais suscetíveis a níveis elevados de sintomas depressivos. Segundo Kimberlé Crenshaw (1989), os sistemas de opressão sobrepostos, racismo e sexismo, acabam por criar desvantagens únicas e cumulativas para as mulheres negras.

Diferentes estudos buscam compreender as bases sociais da maior vulnerabilidade a problemas de saúde mental entre mulheres negras. No estudo de Erving et al. (2022), foi evidenciado que, no geral, as mulheres negras no ambiente acadêmico declararam sofrer “microagressões raciais de gênero” (MRGs) com a frequência de “algumas vezes por ano”, demonstrando que as microagressões não tendem a ser eventos singulares e isolados. Nesse contexto, as MRGs em geral foram associadas a sintomas depressivos mais elevados, e entre as diversas dimensões das microagressões raciais de gênero, o estereótipo da “mulher negra raivosa” apresentou a associação mais forte com sintomas depressivos (Erving et al., 2022).

O arquétipo da “mulher negra raivosa” foi naturalizado por meio de programas de TV e representações exageradas de mulheres negras, como a personagem “Sapphire” do programa de televisão norte-americano exibido na década de 1950, o *Amos 'n' Andy Show*. As mulheres negras que internalizam esse estereótipo podem temer ser percebidas como agressivas, o que gera grande dificuldade em expressar seus sentimentos, e pode causar grande sofrimento mental (Erving et al., 2022; Judd, 2019). Nesse contexto social, as mulheres negras relatam frequentemente ser instruídas a “se acalmar” ou a serem acusadas de “estar com raiva ao falar de maneira calma”. Assim, dada a conotação negativa da caracterização das mulheres

negras como "raivosas", é previsível que tal estereótipo leve a um alto sentimento de angústia nas mulheres negras (Erving et al., 2022).

Outros estereótipos igualmente disseminados também podem ser profundamente prejudiciais. Por exemplo, o estereótipo da "mulher negra forte" frequentemente leva à percepção de que as mulheres negras não precisam ou não merecem apoio (Abrams et al., 2019; Jones et al., 2025; Woods-Giscombé, 2010). Ao internalizar esse estereótipo, as mulheres negras podem ser desencorajadas de realizar comportamentos de busca por ajuda, contribuindo, assim, para a maior prevalência de sintomas depressivos observada neste grupo (Jones et al., 2025).

Estudos mostram que as mulheres negras acreditam que, para "ser fortes", devem suportar o sofrimento, especialmente em solidão, o que resulta em sentimentos de desconexão em relação aos outros (Abrams et al., 2014; Liao et al., 2019). Essa construção do estereótipo da "mulher negra forte" acaba por desenvolver um "perfeccionismo disfuncional", que envolve padrões irrealisticamente elevados, alta percepção de pressão externa, preocupação excessiva com erros e uma discrepância percebida em relação ao próprio desempenho (Liao et al., 2019). Assim, as mulheres negras que internalizam o estereótipo da "mulher negra forte" tornam-se vulneráveis a problemas de saúde mental e a sentimentos de isolamento (Liao et al., 2019).

O estudo de Mowatt et al. (2013) argumenta que as mulheres negras enfrentam também um paradoxo de invisibilidade e hipervisibilidade, sendo invisibilizadas ao merecerem reconhecimento, mas superexpostas como corpos racializados e generificados, sujeitos à estereotipação e vigilância. A invisibilidade é um aspecto fundamental da experiência de "ser negro". No entanto, o corpo negro torna-se visível quando concepções de sujeição sexual ou disparidades sociais são discutidas. Quando os corpos das mulheres negras são expostos para serem sexualizados ou ridicularizados, ou quando agendas sociopolíticas usam as experiências das mulheres negras como bodes expiatórios, elas são superexpostas para servir como "*tokens*". Porém, quando suas contribuições são efetivas e relevantes, as mulheres negras tornam-se invisíveis por meio da sua desvalorização e desacreditação perante a sociedade (Mowatt et al., 2013; Settles et al., 2019). Em conjunto, nossos achados sustentam a ideia de que os espaços acadêmicos podem constituir o que Settles et al. (2019) descrevem como um "paradoxo da

(in)visibilidade”, no qual a presença das mulheres negras é simultaneamente superexposta e desvalorizada. Esse paradoxo amplifica o estresse das minorias, reforçando sentimentos de isolamento e intensificando a vulnerabilidade à depressão. Ao demonstrar empiricamente que as mulheres negras na academia têm o dobro de probabilidade de atender aos critérios para depressão provável em comparação com os homens brancos, nosso estudo estende esse arcabouço teórico ao contexto brasileiro.

Ainda no contexto acadêmico, a psicóloga Kecia M. Thomas, reitora do *College of Arts and Sciences* da Universidade do Alabama em Birmingham, notou um tema perturbador se repetindo ao conduzir entrevistas com mulheres negras. Elas disseram acreditar que eram bem vistas, ainda que fossem “*tokenizadas*” ou superprotegidas por colegas, no início de suas carreiras. Porém, ao pressionarem por oportunidades de crescimento ou expansão de seus papéis, a tolerância benevolente de que desfrutavam se transformou em resistência, quando não em hostilidade declarada. Esse fenômeno foi batizado de “*pet to threat*” e o principal ponto de inflexão identificado foi a ascensão dessas mulheres negras a posições de promoção ou liderança, que é quando as mulheres negras provavelmente estão mais vulneráveis a ser reclassificadas como ameaçadoras (Erete et al., 2021; Showunmi, 2023).

Mesmo em cargos universitários de maior prestígio, as mulheres negras ainda enfrentam desigualdade significativa em termos de suas trajetórias acadêmicas. Um estudo conduzido pelo grupo Parent in Science (2023) analisou a distribuição das bolsas de produtividade em pesquisa (PQ) no Brasil, concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com foco em gênero e raça. Os resultados revelaram que apenas 5,6% de todas as bolsas de produtividade são destinadas às mulheres negras (Parent in Science, 2023). As bolsas PQ são concedidas a docentes universitários de todas as áreas do conhecimento que se destacam por sua produção acadêmica, com o objetivo de reconhecer e apoiar sua produção científica. Os critérios para concessão dessas bolsas incluem produção científica, participação na formação de recursos humanos e contribuições efetivas para o campo de pesquisa (Rezende et al., 2025). As bolsas PQ possuem diferentes níveis e, à medida que o nível e o valor da bolsa aumentam, a representação das mulheres negras diminui, evidenciando um fenômeno

conhecido como “efeito tesoura” (Rossiter, 1995). No nível PQ-Sr, o mais alto possível, não há pessoas autodeclaradas pretas e apenas 6,2% se autodeclararam pardas (Parent in Science, 2023; Arêas da Silva et al., 2021).

A baixa representatividade de mulheres negras no ambiente universitário também pode ser um fator capaz de gerar um estresse psicológico. Segundo revisão da literatura produzida por Calaza et al (2021) , dois fenômenos parecem contribuir de forma significativa nessa questão: o viés implícito e a ameaça pelo estereótipo. O “Viés implícito” é um fenômeno que pode ser compreendido como conceitos ou associações, que aprendemos ao longo da vida, e que são ativados de forma automática, e que podem moldar e guiar nossas impressões, julgamentos, sentimentos e ações (Bargh et al, 1996; Erthal, Oliveira, Volchan & Calaza, 2024). Dessa forma, o viés implícito acaba por prejudicar grupos com baixa representatividade, como as mulheres negras, fazendo com que os próprios indivíduos e a sociedade as enxerguem de forma estigmatizada, gerando comportamentos enviesados, o que pode afetar diretamente o seu desempenho (Steele & Aronson, 1995; Calaza et al., 2021; Salgado et al., 2022). Enquanto o viés implícito pode fazer com que a sociedade enxergue grupos minoritários como inferiores, dado o histórico social de machismo e racismo estruturais presentes na sociedade, a ameaça por estereótipos impacta diretamente o desempenho das mulheres negras, como grupo social. A ameaça pelo estereótipo refere-se a um possível “risco” de confirmar um estereótipo negativo associado a um grupo social como sendo uma característica própria do indivíduo, gerando prejuízos temporários à performance (Calaza et al., 2021, Salgado et al., 2022; Steele & Aronson, 1995).

A discriminação racial também foi capaz de prever indiretamente pior saúde mental por meio da redução da resiliência, um fator importante de proteção contra a depressão e a ansiedade (Daftary et al., 2020). Segundo Erving et al. (2024b), existe um fenômeno conhecido como estresse antecipatório relacionado à raça (*anticipatory race-related stress – ARRS*), que ocorre quando, mesmo na ausência de ameaças raciais ou violência, a tensão racial é capaz de induzir estresse em pessoas negras. Entre as mulheres negras universitárias, o ARRS mostrou-se positivamente associado a sintomas depressivos (Erving et al., 2024b). Em uma revisão, Stoll et al. (2022) discutem como a pressão acadêmica foi um fator

determinante para o sofrimento mental de estudantes negros. Especificamente, as mulheres negras relataram que seus conhecimentos acadêmicos eram excessivamente policiados e escrutinados por docentes, enquanto recursos de apoio à aprendizagem e bem-estar eram menos acessíveis para elas do que para pessoas brancas, o que impactou negativamente sua saúde mental e sua experiência de aprendizagem (Jackson-Cole, 2019).

As universidades se configuram como locais com diferentes políticas públicas para enfrentar o ambiente hostil que muitas mulheres encontram, especialmente no local de trabalho. Esses mecanismos têm como objetivo tornar o ambiente de trabalho mais equitativo, criando oportunidades e tornando-o mais inclusivo, possibilitando que as mulheres possam se sentir acolhidas e desfrutar de progressão na carreira. No entanto, segundo Showunmi (2023), quem se beneficia das diferentes políticas públicas existentes são as mulheres brancas, e não as mulheres negras. O sucesso das mulheres brancas às custas das mulheres negras é descrito em Showunmi et al. (2022) como a “Síndrome da Mulher Branca” (*White Women Syndrome – WWS*). A WWS pode ser definida como o sentimento que muitas mulheres negras vivenciam ao notar que os recursos, que frequentemente são limitados, são destinados exclusivamente às mulheres brancas, fazendo com que as mulheres negras estejam sempre próximas demais do “pote de ouro” (ou seja, do reconhecimento ou recompensa relacionada à carreira), porém, sejam sempre superadas por mulheres brancas (Showunmi et al., 2022; Showunmi, 2023). Reconhecer isso ajuda a situar a forma como o racismo cotidiano pode ser negligenciado. Comportamentos insidiosos e não explicados frequentemente têm origem nesse contexto, e elementos de condutas indesejadas convergem aqui para gerar um forte campo de força que resulta em um racismo sofisticado (Showunmi, 2023).

6. LIMITAÇÕES

Este estudo apresenta algumas limitações. Primeiramente, o estudo foi conduzido durante a pandemia de COVID-19. Não é possível determinar em que medida nossos resultados se devem à pandemia, uma vez que não dispomos de

dados anteriores a esse período. No entanto, a literatura sugere que a pandemia de COVID-19 agravou um cenário já existente de fragilização da saúde mental (Weich, 2022). Em segundo lugar, os dados foram coletados por meio de um método de amostragem em “bola de neve” (snowball sampling), envolvendo a distribuição de um link de questionário via e-mail e WhatsApp. Essa abordagem pode ter restringido o alcance do estudo.

Ademais, a dependência de dados autorrelatados pode afetar a precisão e a confiabilidade das respostas, uma vez que os participantes podem ter subnotificado ou supernotificado determinados sintomas depressivos. Contudo, essa é uma limitação comum em pesquisas online e difícil de ser superada, apesar das contribuições significativas de estudos que utilizam esse tipo de abordagem.

Por fim, a classificação racial baseou-se na autodeclaração. É possível que alguns indivíduos que se autodeclararam pretos ou pardos apresentem um fenótipo tipicamente associado a pessoas brancas (ou o inverso), uma vez que não houve verificação externa para validar a raça autodeclarada. Ainda assim, no Brasil, a autodeclaração é amplamente aceita, inclusive para o acesso a políticas de ação afirmativa.

7. CONCLUSÕES

Em conclusão, nosso estudo sugere que, mesmo quando as mulheres negras alcançam altos níveis educacionais e ocupam posições prestigiosas, elas permanecem o grupo mais vulnerável em termos de saúde mental quando comparadas diretamente às mulheres brancas e aos homens brancos e negros. Os achados ressaltam a necessidade urgente de políticas públicas e ações direcionadas especificamente a esse grupo social, que ultrapassem o apoio genérico em saúde mental e adotem uma perspectiva interseccional. As mulheres negras estão sub-representadas na ciência e na academia, o que gera sentimentos de isolamento e de não pertencimento, podendo contribuir para o sofrimento psíquico. Esforços para ampliar a representação das mulheres negras na academia, como ações de combate ao racismo e ao assédio, são fundamentais para a criação de um ambiente acadêmico mais saudável e inclusivo para todas as pessoas.

8. REFERÊNCIAS

1. Abrams JA, Hill A, Maxwell M. Underneath the mask of the strong Black woman schema: disentangling influences of strength and self-silencing on depressive symptoms among U.S. Black women. *Sex Roles*. 2019;80(9-10):517-26. doi:10.1007/s11199-018-0956-y.
2. Abrams JA, Maxwell M, Pope M, Belgrave FZ. Carrying the world with the grace of a lady and the grit of a warrior: deepening our understanding of the “Strong Black Woman” schema. *Psychol Women Q*. 2014 Dec;38(4):503-18. doi:10.1177/0361684314541418.
3. Aires FRS, Elias TW, Albarello CZ, Freitas ABS. Suicídio masculino e depressão: um problema subdiagnosticado? *Arch Health*. 2025;6(4 Spec):1-5. doi:10.46919/archv6n4espec-16422.
4. Ali R, Iqbal S, Ditta A, Abdullah F. The interplay of workload and health among women in higher education: a systematic review. *ProScholar Insights*. 2025;4(1):214-26. doi:10.62997/psi.2025a-41067.
5. Alzueta E, Perrin P, Baker FC, Caffarra S, Ramos-Usuga D, Yuksel D, et al. How the COVID-19 pandemic has changed our lives: a study of psychological correlates across 59 countries. *J Clin Psychol*. 2021;77(3):e23082. doi:10.1002/jclp.23082.
6. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013.
7. Araújo EM, Xavier KAS, Souza LB, Vichi C. Racismo internalizado: uma perspectiva analítico-comportamental. *Perspect Anal Comport*. 2022;13(1):342-53. doi:10.18761/DH000166.set21.
8. Arday J. Understanding mental health: what are the issues for Black and ethnic minority students at university? *Soc Sci*. 2018;7:232. doi:10.3390/socsci7100232.
9. Arêas da Silva RP, Nodari AC, Cardoso M, Santana AE, Barbosa MC. Misogyny in Brazilian federal government agencies for science and high-education. *An Acad Bras Cienc*. 2021;93(suppl 3):e20201389. doi:10.1590/0001-3765202120201389.
10. Arias D, Saxena S, Verguet S. Quantifying the global burden of mental disorders and their economic value. *eClinicalMedicine*. 2022;54:101675. doi:10.1016/j.eclinm.2022.101675.
11. Arias-de la Torre J, Vilagut G, Ronaldson A, Serrano-Blanco A, Martín V, Peters M, et al. Prevalence and variability of current depressive disorder in 27 European countries: a population-based study. *Lancet Public Health*. 2021;6(10):e729-38. doi:10.1016/S2468-2667(21)00047-5.
12. Auerbach RP, Alonso J, Axinn WG, Cuijpers P, Ebert DD, Green JG, et al. Mental disorders among college students in the World Health Organization World Mental Health Surveys. *Psychol Med*. 2016;46(14):2955-70. doi:10.1017/S0033291716001665.
13. Ayalon L, Young MA. A comparison of depressive symptoms in African Americans and Caucasian Americans. *J Cross Cult Psychol*.

- 2003;34(1):111-24. doi:10.1177/0022022102239158.
14. Baños RM, Miragall M. Gender matters: a critical piece in mental health. *Span J Psychol.* 2024;27:e28. doi:10.1017/SJP.2024.29.
 15. Baptista RM, Bandeira ML, Souza MTS (2018). The invisibility of the Black population in modern slavery: evidence based on conditions of social vulnerability. *Revista Organizações & Sociedade*, 25(87), 676–703. <https://doi.org/10.1590/1984-9250877>.
 16. Barbosa AF (2003). A formação do mercado de trabalho no Brasil: da escravidão ao assalariamento. Tese de doutorado em Economia. Campinas: Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas.
 17. Barcelos-Ferreira R, Izbicki R, Steffens DC, Bottino CMC. Depressive morbidity and gender in community-dwelling Brazilian elderly: systematic review and meta-analysis. *Int Psychogeriatr.* 2010;22(5):712-26. doi:10.1017/S1041610210000463.
 18. Barnes DM, Bates LM. Do racial patterns in psychological distress shed light on the Black-White depression paradox? A systematic review. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol.* 2017;52(8):913-28. doi:10.1007/s00127-017-1394-9.
 19. Bargh JA, Chen M, Burrows L (1996). Automaticity of social behavior: direct effects of trait construct and stereotype activation on action. *Journal of Personality and Social Psychology*, 71(2), 230–244.
 20. Barros LO, Ambiel RAM, Baptista MN. Sintomatologia depressiva em estudantes brasileiros de pós-graduação stricto sensu. *PSICO.* 2021 jul.-set.;52(4):1-12. doi: 10.15448/1980-8623.2021.4.36161.
 21. Barroso SM, Oliveira NR, Andrade VS. Solidão e Depressão: Relações com Características Pessoais e Hábitos de Vida em Universitários. *Psicol Teor Pesqui.* 2019;35:e35427. doi: 10.1590/0102.3772e35427.
 22. Bayram N, Bilgel N. The prevalence and socio-demographic correlations of depression, anxiety and stress among a group of university students. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol.* 2008 ago. 1;43(8):667-72. doi: 10.1007/s00127-008-0345-x.
 23. Bhui K, Ascoli M, Nuamh O. The place of race and racism in cultural competence: what can we learn from the English experience about the narratives of evidence and argument? *Transcult Psychiatry.* 2012;49(2):185-205. doi:10.1177/1363461512437589.
 24. Bhui K. Gender, power and mental illness. *Br J Psychiatry.* 2018;212(3):191-2. doi:10.1192/bjp.2018.30.
 25. Boas AAV, Morin AM. Psychological well-being and psychological distress for professors in brazil and canada. *RAM Rev Adm Mackenzie.* 2014 dez.;15(6):201-19. doi: 10.1590/1678-69712014/administracao.v15n6p201-219.
 26. Borsoi ICF. Trabalho e produtivismo: saúde e modo de vida de docentes de instituições públicas de Ensino Superior. *Cad. psicol. soc. trab..* 2012 jun.;15(1):81-100.
 27. Bourdieu P. Masculine domination. Stanford (CA): Stanford University Press; 2001.

28. Brown-Iannuzzi JL, Adair KC, Payne BK, Smart Richman L, Fredrickson BL. Discrimination hurts, but mindfulness may help: trait mindfulness moderates the relationship between perceived discrimination and depressive symptoms. *Pers Individ Dif*. 2014;56:201-5. doi:10.1016/j.paid.2013.09.015.
29. Bryant BE, Jordan A, Clark US. Race as a social construct in psychiatry research and practice. *JAMA Psychiatry*. 2022 Feb;79(2):93-4. doi:10.1001/jamapsychiatry.2021.2877.
30. Bryant K, Greer-Williams N, Willis N, Hartwig M. Barriers to Diagnosis and Treatment of Depression: Voices from a Rural African-American Faith Community. *J Natl Black Nurses Assoc*. 2013 jul.;24(1):31-8.
31. Calaza KC, et al. (2021). Facing racism and sexism in science by fighting against social implicit bias: a Latina and Black woman's perspective. *Frontiers in Psychology*, 12, 671481. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.671481>.
32. Caldeira TCM, da Silva LES, Claro RM, Damião JJ, Canella DS, de Sousa TM. Racial inequality in the prevalence of symptom-based depression versus self-reported medical diagnosis in Brazil. *J Racial Ethn Health Disparities*. 2025 Apr 14 [Epub ahead of print]. doi:10.1007/s40615-025-02397-7. PubMed PMID: 40227379.
33. Caldwell LD, Bledsoe KL. Can social justice live in a house of structural racism? A question for the field of evaluation. *Am J Eval*. 2019;40(1):6-18. doi:10.1177/1098214018815772.
34. Carneiro AS. A construção do outro como não-ser como fundamento do ser [tese de doutorado]. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2005. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/001465832>. Acesso em: 2026 jan. 05.
35. Carvalho D (2021). O legado do sistema colonial escravagista como base para a gênese do sistema capitalista no Brasil: a persistência do racismo no cotidiano da população negra. *Cadernos Cemarx*, 14(00), e021006. <https://doi.org/10.20396/cemarx.v14i00.15223>.
36. Cen S, Zhao M, Wang F, Tang L. Gender differences in the relationship between mental health and academic performance among undergraduate students at a medical school in Shanghai: a cross-sectional study. *BMC Public Health*. 2025;25:731. doi:10.1186/s12889-025-21697-5.
37. Cepoiu M, McCusker J, Cole MG, Sewitch M, Belzile E, Ciampi A. Recognition of depression by non-psychiatric physicians—a systematic literature review and meta-analysis. *J Gen Intern Med*. 2008 jan.;23(1):25-36. doi: 10.1007/s11606-007-0428-5.
38. Chae DH, Powell WA, Nuru-Jeter AM, Smith-Bynum MA, Seaton EK, Forman TA, et al. The role of racial identity and implicit racial bias in self-reported racial discrimination: implications for depression among African American men. *J Black Psychol*. 2017;43(8):789-812. doi:10.1177/0095798417690055.
39. Chor D, Lima CRA. Aspectos epidemiológicos das desigualdades raciais em saúde no Brasil / Epidemiologic aspects of racial inequalities in health in Brazil. *Cad Saude Publica*. 2005;21(5):1586-94. doi:10.1590/S0102-311X2005000500033.
40. Collins PH. Intersectionality's definitional dilemmas. *Annu Rev Sociol*.

- 2015;41:1-20. doi:10.1146/annurev-soc-073014-112142.
41. Connell RW, Messerschmidt JW. Hegemonic masculinity: rethinking the concept. *Gend Soc.* 2005;19(6):829-59. doi:10.1177/0891243205278639.
 42. Constante HM, Bastos JL, Ruiz MA. The more you need, the less you get: intersectionality and the inverse care law in the Brazilian depression care cascade. *Ethn Health.* 2023;28(4):488-502. doi:10.1080/13557858.2022.2078483.
 43. Courtenay WH. Constructions of masculinity and their influence on men's well-being: a theory of gender and health. *Soc Sci Med.* 2000;50(10):1385-401. doi:10.1016/S0277-9536(99)00390-1.
 44. COVID-19 Mental Disorders Collaborators. Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. *Lancet.* 2021;398:1700-12. doi:10.1016/S0140-6736(21)02143-7.
 45. Crenshaw K. Demarginalizing the intersection of race and sex: a black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *Univ Chic Leg Forum.* 1989;1989(1):139-67. Disponível em: <http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8>.
 46. Daftary AM, Devereux P, Elliott M. Discrimination, depression, and anxiety among college women in the Trump era. *J Gend Stud.* 2020;29(4):438-51. doi:10.1080/09589236.2020.1767546.
 47. Das AK, Olsson M, McCurtis HL, Weissman MM. Depression in African Americans: breaking barriers to detection and treatment. *J Fam Pract.* 2006;55(1):30-9. PMID: 16388764.
 48. Devries KM, Mak JY, Bacchus LJ, Child JC, Falder G, Petzold M, et al. Intimate partner violence and incident depressive symptoms and suicide attempts: a systematic review of longitudinal studies. *PLoS Med.* 2013;10(5):e1001439. doi:10.1371/journal.pmed.1001439.
 49. Dias LO, Castro ALM. Mulheres negras nas universidades e saberes decoloniais: por uma teorização de um pensamento feminista negro. *Monções Rev Relac Int UFGD.* 2020;9(17):535-61. doi: 10.30612/rmufgd.v9i17.10293.
 50. Diehl L, Marin AH. Adoecimento mental em professores brasileiros: revisão sistemática da literatura. *Estud Interdiscip Psicol.* 2016 dez.;7(2):64-85. doi: 10.5433/2236-6407.2016v7n2p64.
 51. Duric P, Harhaji S, O'May F, Boderscova L, Chihai J, Como A, et al. General practitioners' views towards diagnosing and treating depression in five southeastern European countries. *Early Interv Psychiatry.* 2019 out.;13(5):1155-64. doi: 10.1111/eip.12747.
 52. Eagly AH, Wood W. The origins of sex differences in human behavior: evolved dispositions versus social roles. *Am Psychol.* 1999;54(6):408-23. doi:10.1037/0003-066X.54.6.408.
 53. Eagly AH, Wood W. Social role theory. In: Van Lange PAM, Kruglanski AW, Higgins ET, editors. *Handbook of theories of social psychology.* London: Sage Publications Ltd; 2012. p. 458-76. doi:10.4135/9781446249222.n49.
 54. Erete S, Rankin YA, Thomas JO. "I can't breathe: reflections from black

- women in CSCW and HCI.” *Proc ACM Hum-Comput Interact.* 2021;4(CSCW2):1-23. doi:10.1145/3432933.
55. Erthal FS, Oliveira L, Calaza KC (2024). Como diminuir as desigualdades de gênero e raça na ciência? Enfrentando o viés implícito socialmente construído. In: Oliveira L, Roque T, organizadoras. *Mulheres na ciência: o que mudou e o que ainda precisamos mudar*. Rio de Janeiro: Oficina Raquel.
 56. Erving CL, Frazier C, Davidson-Turner KJ. Who cares for Black women in health and health care: are characteristics associated with strong Black womanhood linked to depression in older Black women? *Womens Health (Lond)*. 2024;20:17455057241274923. doi:10.1177/17455057241274923.
 57. Erving CL, Satcher LA, Chen Y. Psychologically resilient, but physically vulnerable? Exploring the psychosocial determinants of African American women's mental and physical health. *Sociol Race Ethn*. 2020;6(1):117-34. doi:10.1177/2332649219900284.
 58. Erving CL, Williams TR, Frierson W, Derisse M. Gendered racial microaggressions, psychosocial resources, and depressive symptoms among Black women attending a historically Black university. *Soc Ment Health*. 2022;12(3):230-47. doi:10.1177/21568693221115766.
 59. Evanoff BA, Strickland JR, Dale AM, Hayibor L, Page E, Duncan JG, et al. Fatores relacionados ao trabalho e pessoais associados ao bem-estar mental durante a resposta à COVID-19: pesquisa com profissionais de saúde e outros trabalhadores. *J Med Internet Res*. 2020;22(8):e21366. doi:10.2196/21366.
 60. Evans TM, Bira L, Gastelum JB, Weiss LT, Vanderford NL. Evidence for a mental health crisis in graduate education. *Nat Biotechnol*. 2018 mar. 6;36(3):282-4. doi: 10.1038/nbt.4089.
 61. Fan Y, Fan A, Yang Z, Fan D. Global burden of mental disorders in 204 countries and territories, 1990–2021: results from the global burden of disease study 2025. *BMC Psychiatry*. 2025;25:486. doi:10.1186/s12888-025-06932-y.
 62. Farber R, Wedell E, Herchenroeder L, Dickter CL, Pearson MR, Bravo AJ. Microaggressions and psychological health among college students: a moderated mediation model of rumination and social structure beliefs. *J Racial Ethn Health Disparities*. 2021;8(1):245-55. doi:10.1007/s40615-020-00778-8.
 63. Goldman LS, Nielsen NH, Champion HC, Council on Scientific Affairs, American Medical Association. Awareness, Diagnosis, and Treatment of Depression. *J Gen Intern Med*. 1999 set.;14(9):569-80. doi: 10.1046/j.1525-1497.1999.03478.x.
 64. Gonzales L, Hasenbalg C. *Lugar de negro*. Rio de Janeiro: Marco Zero; 1982.
 65. Gonzalez L (2018). *Primavera para as rosas negras: Lélia Gonzalez em primeira pessoa*. São Paulo: Diáspora Africana; União dos Coletivos Pan-Africanistas.
 66. Grey T, Sewell H, Shapiro G, Ashraf F. Mental health inequalities facing UK minority ethnic populations: causal factors and solutions. *J Psychol Issues Organ Cult*. 2013;3(S1):146-57. doi:10.1002/jpoc.21080.
 67. Halat HD, Soltani A, Dalli R, Alsarraj L, Malki A. Understanding and fostering

- mental health and well-being among university faculty: a narrative review. *J Clin Med*. 2023;12:4425. doi:10.3390/jcm12134425.
68. Hall NM, Dickens DD, Minor KA, Thomas Z, Mitchell C, Johnson N. The strong Black woman stereotype and identity shifting among Black women in academic and other professional spaces. *Womens Health (Lond)*. 2025;21:17455057251335358. doi:10.1177/17455057251335358.
 69. Hall WJ, Chapman MV, Lee KM, Merino YM, Thomas TW, Payne BK, et al. Implicit racial/ethnic bias among health care professionals and its influence on health care outcomes: a systematic review. *Am J Public Health*. 2015;105(12):e60-e76. doi:10.2105/AJPH.2015.302903.
 70. Hatzenbuehler ML, Link BG. Introduction to the special issue on structural stigma and health. *Soc Sci Med*. 2014;103:1-6. doi:10.1016/j.socscimed.2013.12.017.
 71. Henriques CS. A educação das mulheres negras trabalhadoras no Brasil: um direito a ser conquistado. In: *Anais do Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women's Worlds Congress* [Internet]; 2017 Jul 30-Ago 4; Florianópolis, SC. Florianópolis: Seminário Internacional Fazendo Gênero; 2017 [citado 2026 Jan 20]. Disponível em: https://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1494369788_ARQUIVO_CIBELEHENRIQUES-UFSC-FAZENDOGENERO-2017.pdf. ISSN 2179-510X.
 72. Hintz AM, Gomes-Filho IS, Loomer PM, Pinho PS, Passos-Soares JS, Trindade SC, et al. Depression and associated factors among Brazilian adults: the 2019 national healthcare population-based study. *BMC Psychiatry*. 2023;23:704. doi:10.1186/s12888-023-05133-9.
 73. Hudson DL, Neighbors HW, Geronimus AT, Jackson JS (2016). Racial discrimination, John Henryism, and depression among African Americans. *Journal of Black Psychology*, 42(3), 221–243. <https://doi.org/10.1177/0095798414567757>.
 74. Hyde JS, Mezulis AH, Abramson LY. The ABCs of depression: integrating affective, biological, and cognitive models to explain the emergence of the gender difference in depression. *Psychol Rev*. 2008;115(2):291-313. doi:10.1037/0033-295X.115.2.291.
 75. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Pesquisa Nacional de Saúde 2019: ciclos de vida*. Rio de Janeiro: IBGE; 2021. ISBN: 978-65-87201-76-4.
 76. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: outras formas de trabalho 2022*. Rio de Janeiro: IBGE; 2023. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102020_informativo.pdf. Acesso em: 05 jan. 2024.
 77. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 2019*. Rio de Janeiro: IBGE; 2019. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101678.pdf>. Acesso em: 1

fev. 2026.

78. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2022: identificação étnico-racial da população, por sexo e idade: resultados do universo [Internet]. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 2023 [citado 2025 Dez 09]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?id=73105>
79. Instituto Cidades Sustentáveis, Ipec. Pesquisa Viver nas Cidades: Mulheres. São Paulo: Instituto Cidades Sustentáveis; 2025 Mar 11 [citado 2026 Jan 19]. Disponível em: https://nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2025/03/Pesquisa-Mulheres-2025_ICS-Ipec.pdf.
80. Instituto Locomotiva. Vivências e demandas das mulheres por segurança no deslocamento [Internet]. São Paulo: Instituto Patrícia Galvão; 2024 [citado 2026 Jan 19]. Disponível em: <https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-e-fontes/pesquisa/vivencias-e-demandas-das-mulheres-por-seguranca-no-deslocamento-instituto-patricia-galvao-instituto-locomotiva-2024/>.
81. Jackson-Cole D. Navigating toward success: Black and minority ethnic students in postgraduate science, technology, engineering and mathematics courses in England [tese de doutorado]. London: University of East London; 2019.
82. Jones MK, Hill-Jarrett TG, Jean-Ceide C. The strong Black woman schema and mental health: examining the role of personal mastery. *J Black Psychol.* 2025;51(5):617-41. doi:10.1177/00957984241308778.
83. Jones MS, Womack V, Jérémie-Brink G, Dickens DD. Gendered racism and mental health among young adult U.S. Black women: the moderating roles of gendered racial identity centrality and identity shifting. *Sex Roles.* 2021;85(3-4):221-31. doi:10.1007/s11199-020-01214-1.
84. Judd B. Sapphire as praxis: toward a methodology of anger. *Fem Stud.* 2019;45(1):178-208. doi:10.15767/feministstudies.45.1.0178.
85. Keating F. African and African Caribbean men and mental health. Better Health Briefing Paper 5 [Internet]. London: Race Equality Foundation; 2007 [citado 2026 Jan 13]. Disponível em: <https://raceequalityfoundation.org.uk/wp-content/uploads/2022/10/health-brief5.pdf>.
86. Kiely KM, Brady B, Byles J. Gender, mental health and ageing. *Maturitas.* 2019;129:76-84. doi:10.1016/j.maturitas.2019.09.004.
87. Kisa A, Kisa S. Structural racism as a fundamental cause of health inequities: a scoping review. *Int J Equity Health.* 2025;24:257. doi:10.1186/s12939-025-02644-7.
88. Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. *J Gen Intern Med.* 2001;16(9):606-13. doi:10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x.
89. Kuehner C. Why is depression more common among women than among men? *Lancet Psychiatry.* 2017;4(2):146-58.

- doi:10.1016/S2215-0366(16)30263-2.
90. Lagdon S, Armour C, Stringer M. Adult experience of mental health outcomes as a result of intimate partner violence victimisation: a systematic review. *Eur J Psychotraumatol*. 2014;5:24794. doi:10.3402/ejpt.v5.24794.
 91. Lana RSM, Nudelman MF, Alves SR, Junior OF, Gonçalves RM, Machado AV, et al. Vulnerability and protective factors for PTSD in the academic community during the pandemic. *Psicol Reflex Crit*. 2026 jan. 15;39(1):1. doi: 10.1186/s41155-025-00372-z.
 92. Law I. Building the anti-racist university, action and new agendas. *Race Ethn Educ*. 2017;20(3):332-43. doi:10.1080/13613324.2016.1260232.
 93. Leighton K, Kardong-Edgren S, Schneidereith T, Foisy-Doll C. Using social media and snowball sampling as an alternative recruitment strategy for research. *Clin Simul Nurs*. 2021;55:37-42. doi:10.1016/j.ecns.2021.03.006.
 94. Levecque K, Anseel F, Beuckelaer AD, Van Der Heyden J, Gisle L. Work organization and mental health problems in PhD students. *Res Policy*. 2017;46(4):868-79. doi:10.1016/j.respol.2017.02.008.
 95. Liao KYH, Wei M, Yin M. The misunderstood schema of the strong Black woman: exploring its mental health consequences and coping responses among African American women. *Psychol Women Q*. 2019;43(1):1-21. doi:10.1177/0361684319883198.
 96. Lima MFEM, Lima-Filho DO. Condições de trabalho e saúde do/a professor/a universitário/a. *Ciênc. cogn.*. 2009;14(3):62-82. Disponível em: <https://revista.cienciasecognicao.org/index.php/cec/article/view/253>.
 97. Lincoln KD, Taylor RJ, Watkins DC, Chatters LM. Correlates of psychological distress and major depressive disorder among African American men. *Res Soc Work Pract*. 2011;21(3):278-88. doi:10.1177/1049731510386122.
 98. Loades ME, Chatburn E, Higson-Sweeney N, Reynolds S, Shafran R, Brigden A, et al. Rapid systematic review: the impact of social isolation and loneliness on the mental health of children and adolescents in the context of COVID-19. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*. 2020;59(11):1218-39.e3. doi:10.1016/j.jaac.2020.05.009.
 99. Longmire-Avital B, Robinson R. Young, depressed, and Black: a comparative exploration of depressive symptomatology among Black and White collegiate women. *J Coll Student Psychother*. 2017;31(4):297-311. doi:10.1080/87568225.2017.1344114.
 100. Luo MM, Hao M, Li XH, Liao J, Wu CM, Wang Q. Prevalence of depressive tendencies among college students and the influence of attributional styles on depressive tendencies in the post-pandemic era. *Front Public Health*. 2024;12:1326582. doi:10.3389/fpubh.2024.1326582.
 101. Luu X, Abraham V. Racism as a social determinant of mental health in higher education: sector-level perspectives from South Africa and Australia. *Int J Public Health*. 2024 Nov 22 [Epub ahead of print]. doi:10.3389/ijph.2024.1607502.
 102. Manaf MRA, Shaharuddin MAA, Nawi AM, Tauhid NM, Othman H, Rahman MRA, et al. Perceived symptoms of depression, anxiety and stress amongst

- staff in a Malaysian public university: a workers survey. *Int J Environ Res Public Health*. 2021;18(22):11874. doi:10.3390/ijerph182211874.
103. Martin CL, Ghastine L, Wegienka G, Wise LA, Baird DD, Vines AI. Early life disadvantage and the risk of depressive symptoms among young Black women. *J Racial Ethn Health Disparities*. 2024;11(3):1819-28. doi:10.1007/s40615-023-01654-x.
 104. Martins JR, Santos MAC (2023). A depressão nas mulheres negras brasileiras: um estudo acerca do racismo estrutural e seu impacto psíquico [Brazilian black women's depression: a study about structural racism and its psychic impact]. *ACiS*, 11(1), 37–60.
 105. Meeks K, Sutton Peak A, Dreihaus A. Depression, anxiety, and stress among students, faculty, and staff. *J Am Coll Health*. 2023;71(2):348-54. doi:10.1080/07448481.2021.1891913.
 106. Michaels EK, Board C, Mujahid MS, Riddell CA, Chae DH, Johnson RC, et al. Area-level racial prejudice and health: a systematic review. *Health Psychol*. 2022;41(3):211-24. doi:10.1037/hea0001141.
 107. Ministério da Saúde. Depressão [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; s.d. [citado em 10 jan 2026]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/depressao>.
 108. Mirón J, Goldberg X, López-Solà C, Nadal R, Armario A, Andero R, et al. Perceived Stress, Anxiety and Depression Among Undergraduate Students: An Online Survey Study. *J Depress Anxiety*. 2019;8(1):1000330. doi:10.4172/2167-1044.1000330.
 109. Moura BF. Diretores e gerentes negros ganham 34% menos que brancos, revela IBGE. Agência Brasil [Internet]. 2025 Dez 3 [citado 2026 Jan 12]. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-12/diretores-e-gerente-s-negros-ganham-34-menos-que-brancos-revela-ibge>.
 110. Mowatt RA, French BH, Malebranche DA. Black/female/body hypervisibility and invisibility: a race, gender, and body analysis. *J Leis Res*. 2013;45(5):644-60. doi:10.18666/jlr-2013-v45-i5-4367.
 111. Mrejen M, Hone T, Rocha R. Desigualdades socioeconômicas e raciais/étnicas na prevalência de depressão e na lacuna de tratamento no Brasil: uma análise de decomposição. *SSM Popul Health*. 2022;20:101266. doi:10.1016/j.ssmph.2022.101266.
 112. Musse FCC, Castro LS, Mestre TF, Pelloso SM, Poyares D, Musse JLL, et al. Violência mental: ansiedade e depressão durante a pandemia de COVID-19 no Brasil. *Saúde Pesq*. 2022;15(1):e9684. doi:10.17765/2176-9206.2022v15n1.e9684.
 113. Newcomb ME, Hill R, Buehler K, Ryan DT, Whitton SW, Mustanski B. High burden of mental health problems, substance use, violence, and related psychosocial factors in transgender, non-binary, and gender diverse youth and young adults. *Arch Sex Behav*. 2020;49(2):645-59. doi:10.1007/s10508-019-01533-9.
 114. Oates G, DeMaris A. Black-White differences in the reciprocal relationship

- between perceived discrimination and psychological distress. *Sociol Q.* 2022;63(3):470-96. doi:10.1080/00380253.2021.1880301.
115. Okazaki S. Impact of racism on ethnic minority mental health. *Perspect Psychol Sci.* 2009;4(1):103-7. doi:10.1111/j.1745-6924.2009.01099.x.
 116. Olfson M, Zuvekas SH, McClellan C, Wall MM, Hankerson SH, Blanco C. Racial-ethnic disparities in outpatient mental health care in the United States. *Psychiatr Serv.* 2023;74:674-83. doi:10.1176/appi.ps.20220365.
 117. Oliffe JL, Ogradniczuk JS, Gordon SJ, Creighton G, Kelly MT, Black N, et al. Stigma in male depression and suicide: a Canadian sex comparison study. *Community Ment Health J.* 2016;52(3):302-10. doi:10.1007/s10597-015-9986-x.
 118. Organização Mundial da Saúde. Relatório da OMS revela que desigualdades de gênero estão na raiz da crise global no trabalho em saúde e cuidados [Internet]. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2024 Mar 13 [citado 2025 Dez 10]. Disponível em: <https://www.who.int/news/item/13-03-2024-who-report-reveals-gender-inequalities-at-the-root-of-global-crisis-in-health-and-care-work>.
 119. Organização Pan-Americana da Saúde. Mais de um bilhão de pessoas vivem com condições de saúde mental; serviços precisam de ampliação urgente [Internet]. Washington, D.C.: Organização Pan-Americana da Saúde; 2025 Sep 2 [citado 2025 Dez 28]. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/2-9-2025-mais-um-bilhao-pessoas-vivem-com-condicoes-saude-mental-servicos-precisam>.
 120. Otten D, Tibubos AN, Schomerus G, Brähler E, Binder H, Kruse J, et al. Similarities and differences of mental health in women and men: a systematic review of findings in three large German cohorts. *Front Public Health.* 2021;9:553071. doi:10.3389/fpubh.2021.553071.
 121. Parent in Science. Research productivity grants: an analysis by the Parent in Science Movement [Internet]. Porto Alegre: Parent in Science; 2023. Disponível em: <https://www.parentinscience.com/documentos>.
 122. Park J, Lee S, Park G, Woodward S. Mental health help-seeking behaviours of East Asian immigrants: a scoping review. *Eur J Psychotraumatol.* 2025;16(1):2514327. doi:10.1080/20008066.2025.2514327.
 123. Pierce M, Hope H, Ford T, Hatch S, Hotopf M, John A, et al. Mental health before and during the COVID-19 pandemic: a longitudinal probability sample survey of the UK population. *Lancet Psychiatry.* 2020;7(10):883-92. doi:10.1016/S2215-0366(20)30308-4.
 124. Plant EA, Peruche BM. The consequences of race for police officers' responses to criminal suspects. *Psychol Sci.* 2005;16(3):180-3. doi:10.1111/j.0956-7976.2005.00800.x.
 125. Regehr C, Glancy D, Pitts A. Interventions to reduce stress in university students: a review and meta-analysis. *J Affect Disord.* 2013 maio 15;148(1):1-11. doi: 10.1016/j.jad.2012.11.026. Epub 2012 dez. 13.
 126. Rehm J, Shield KD. Global burden of disease and the impact of mental and addictive disorders. *Curr Psychiatry Rep.* 2019;21:10.

- doi:10.1007/s11920-019-0997-0.
127. Rezende LR, Branco VTF, Savasini KV, Luz MP, Casagrande MDT, Thives LP, et al. Criteria for research productivity grants in Brazil applied to civil engineering: reflections on gender differences and the current context. *An Acad Bras Cienc*. 2025;97(1):e20240562. doi:10.1590/0001-3765202520240562.
 128. Rocha S, Staniscuaski F, Nudelman MF, Lana R, Martins RM, Fernandes O Jr, et al. The impact of parenthood on mental health within the academic community: highlighting vulnerabilities and identifying high-risk groups. *Humanit Soc Sci Commun*. 2025;12:893. doi:10.1057/s41599-025-05178-z.
 129. Rollock N. How much does your university do for racial equality? *The Guardian* [Internet]. 2016 Jan 19 [citado 2026 Jan 13]. Disponível em: <https://www.theguardian.com/higher-education-network/2016/jan/19/how-much-does-your-university-do-for-racial-equality/>.
 130. Rossiter MW. *Women Scientists in America: Before Affirmative Action, 1940-1972*. Baltimore (MD): Johns Hopkins University Press; 1995.
 131. Rubach C, von Keyserlingk L, Simpkins SD, Eccles JS. Does instructional quality impact male and female university students differently? Focusing on academic stress, academic satisfaction, and mental health impairment. *Front Educ*. 2022;7:820321. doi:10.3389/feduc.2022.820321.
 132. Salerno JP, Zambrana RE. Depression disparities among sexual and racial minority faculty in the United States. *Psychiatry Res*. 2024;339:116053. doi:10.1016/j.psychres.2024.116053.
 133. Salgado L, Calaza K, Herdy I, Martins S, Barcellos R, Avelino M (2022). #include <meninas.uff>: desconstruindo estereótipos como ferramenta de empoderamento das mulheres na área da computação. *Computação Brasil*, (48), 34–37. <https://doi.org/10.5753/compbr.2022.48.2755>.
 134. Salk RH, Hyde JS, Abramson LY. Gender differences in depression in representative national samples: meta-analyses of diagnoses and symptoms. *Psychol Bull*. 2017;143(8):783-822. doi:10.1037/bul0000102.
 135. Santos RF, Rossetto ER. Feminismo, culturas infantis, gênero e raça: uma reflexão sobre ser menina negra. *Zero-a-Seis*. 2018;20(37):157-69. doi: 10.5007/1980-4512.2018v20n37p157.
 136. Sattar K, Yusoff MSB, Arifin WN, et al. Effective coping strategies utilised by medical students for mental health disorders during undergraduate medical education-a scoping review. *BMC Med Educ*. 2022;22:121. doi: 10.1186/s12909-022-03185-1.
 137. Schnittker J. The proximity of common unhappiness and misery. *Soc Ment Health*. 2012;2(2):135-53. doi:10.1177/2156869312451153.
 138. Schuch, H. S., M. G. Cademartori, V. D. Dias, M. L. Levandowski, T. N. Munhoz, e P. C. Hallal. 2023. "Depression and anxiety among the university community during the Covid-19 pandemic: A study in Southern Brazil." *Anais da Academia Brasileira de Ciências* 95 (1): e20220100.
 139. Schwartz S, Meyer IH. Mental health disparities research: the impact of within and between group analyses on tests of social stress hypotheses. *Soc*

- Sci Med. 2010;70(8):1111-8. doi:10.1016/j.socscimed.2009.12.032.
140. Settles IH, Buchanan NT, Dotson K. Scrutinized but not recognized: (In)visibility and hypervisibility experiences of faculty of color. *J Vocat Behav.* 2019;113:62-74. doi:10.1016/j.jvb.2019.03.006.
 141. Shen H. Employee benefits: plight of the postdoc. *Nature.* 2015;525(7568):279-81. doi:10.1038/nj7568-279a.
 142. Shim RS. Dismantling structural racism in psychiatry: a path to mental health equity. *Am J Psychiatry.* 2021;178(7):592-598. doi:10.1176/appi.ajp.2021.21060558.
 143. Showunmi V. Visible, invisible: Black women in higher education. *Front Sociol.* 2023;8:974617. doi:10.3389/fsoc.2023.974617.
 144. Silva MT, Galvão TF, Martins SS, Pereira MG. Prevalence of depression morbidity among Brazilian adults: a systematic review and meta-analysis. *Rev Bras Psiquiatr.* 2014;36:262-70. doi:10.1590/1516-4446-2013-1294.
 145. Smolen JR, Araújo EM. Race/skin color and mental health disorders in Brazil: a systematic review of the literature. *Cien Saude Colet.* 2017;22(12):4021-30. doi:10.1590/1413-812320172212.19782016.
 146. Smolen JR, de Araújo EM, de Oliveira NF, de Araújo TM. Intersectionality of race, gender, and common mental disorders in Northeastern Brazil. *Ethn Dis.* 2018;28(3):207-14. doi:10.18865/ed.28.3.207.
 147. Spikes T, Higgins M, Lewis T, Dunbar S. The effect of contextualized racial and gendered stressors, social support, and depression on hypertension illness perceptions and hypertension medication adherence in young African American women with hypertension. *J Cardiovasc Nurs.* 2020;35(6):576-87. doi:10.1097/JCN.0000000000000671.
 148. Staniscuaski F, Kmetzsch L, Soletti RC, Reichert F, Zandonà E, Ludwig ZMC, et al. Gender, race and parenthood impact academic productivity during the COVID-19 pandemic: from survey to action. *Front Psychol.* 2021;12:663252. doi:10.3389/fpsyg.2021.663252.
 149. Steele CM, Aronson J (1995). Stereotype threat and the intellectual test performance of African Americans. *Journal of Personality and Social Psychology*, 69(5), 797–811.
 150. Stoll N, Yalipende Y, Byrom NC, Hatch SL, Lempp H. Mental health and mental well-being of Black students at UK universities: a review and thematic synthesis. *BMJ Open.* 2022;12:e050720. doi:10.1136/bmjopen-2021-050720.
 151. Sue DW, Capodilupo CM, Torino GC, Bucceri JM, Holder AMB, Nadal KL, et al. Racial microaggressions in everyday life: implications for clinical practice. *Am Psychol.* 2007;62(4):271-86. doi:10.1037/0003-066X.62.4.271.
 152. Taylor B, Zhao Y, Perez NB, Potts-Thompson S, Crusto C, Creber RM, Taylor JY. Epigenome-wide association study of depressive symptoms in Black women in the InterGEN study. *Int J Mol Sci.* 2024;25:7681. doi:10.3390/ijms25147681.
 153. Thomas KM, Johnson-Bailey J, Phelps RE, Tran NM, Johnson L. From pets to threats: creating a parallel narrative for professional black women. In: Comas-Díaz L, Rivera ET, editors. *Psychological Health of Women of Color:*

- Intersections, Challenges, and Opportunities. Westport, CT: Praeger Publishers; 2013. p. 155-72.
154. Uebelacker LA, Strong D, Weinstock LM, Miller IW. Use of item response theory to understand differential functioning of DSM-IV major depression symptoms by race, ethnicity and gender. *Psychol Med*. 2009;39(4):591-601. doi:10.1017/S0033291708003875.
 155. Visier-Alfonso ME, Sarabia-Cobo C, Cobo-Cuenca AI, Nieto-López M, López-Honrubia R, Bartolomé-Gutiérrez R, et al. Stress, mental health, and protective factors in nursing students: An observational study. *Nurse Educ Today*. 2024 out.;139:106258. doi: 10.1016/j.nedt.2024.106258.
 156. Weaver A, Himle JA, Taylor RJ, Matusko NN, Abelson JM. Urban vs rural residence and the prevalence of depression and mood disorder among African American women and non-Hispanic white women. *JAMA Psychiatry*. 2015;72(6):576-83. doi:10.1001/jamapsychiatry.2015.10.
 157. Weich S. Mental health after COVID-19: the risks are clear, it's now time to learn and respond. *BMJ*. 2022 Feb 16;376:o326. doi:10.1136/bmj.o326.
 158. Wilkins-Yel KG, Arnold A, Bekki J, Natarajan M, Bernstein B, Randall AK. "I can't push off my own Mental Health": Chilly STEM Climates, Mental Health, and STEM Persistence among Black, Latina, and White Graduate Women. *Sex Roles*. 2022;86(3-4):208-32. doi:10.1007/s11199-021-01262-1
 159. Woods-Giscombé CL. Superwoman schema: African American women's views on stress, strength, and health. *Qual Health Res*. 2010 May;20(5):668-83. doi:10.1177/1049732310361892.
 160. World Health Organization (WHO). 2022. "COVID-19 Pandemic Triggers 25% Increase in Prevalence of Anxiety and Depression Worldwide." World Health Organization, March 2, 2022. <https://www.who.int/news/item/02-03-2022-covid-19-pandemic-triggers-25-increase-in-prevalence-of-anxiety-and-depression-worldwide>.
 161. World Health Organization. Comprehensive mental health action plan 2013-2030 [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2022 [citado em 10 jan 2026]. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240031029>.
 162. World Health Organization. Depressive disorder (depression) [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2025 Aug 29 [citado 2025 Dez 28]. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>.
 163. Xiong J, Lipsitz O, Nasri F, Lui LMW, Gill H, Phan L, et al. Impact of COVID-19 pandemic on mental health in the general population: A systematic review. *J Affect Disord*. 2020;277:55-64. doi:10.1016/j.jad.2020.08.001.

9. ANEXOS

9.1 Imagens e Tabelas

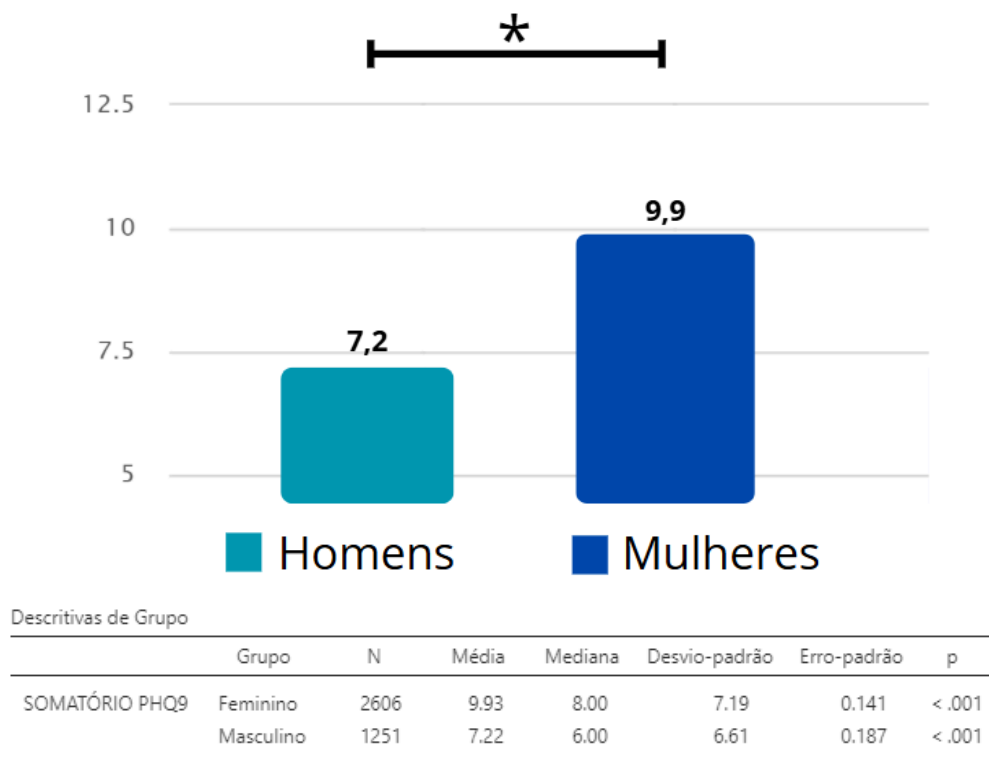
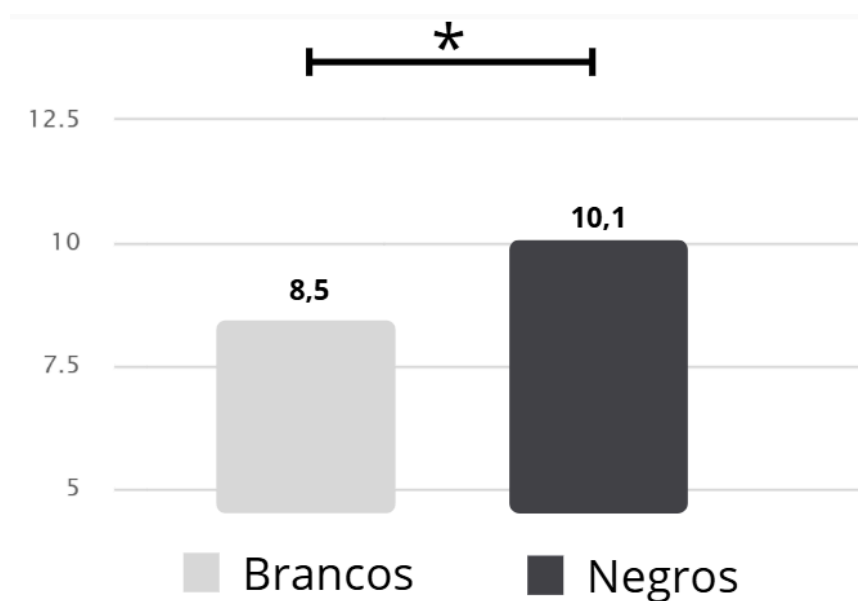


Figura 4: As mulheres pontuaram significativamente mais que os homens, utilizando o teste t de Mann-Whitney ($p < 0.001$). * = $p < 0.05$.



Descritivas de Grupo							
	Grupo	N	Média	Mediana	Desvio-padrão	Erro-padrão	p
SOMATÓRIO PHQ9	Branca	2571	8.52	7.00	6.97	0.137	< .001
	Negra	1286	10.1	9.00	7.30	0.204	< .001

Figura 5: As pessoas que se declararam negras pontuam significativamente mais que as pessoas que se identificam como brancas, utilizando o teste t de Mann-Whitney ($p < .001$). * = $p < 0.05$.

9.2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Pesquisado

REGISTRO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Informações aos participantes

1) Dados de identificação do projeto

Título do Projeto: Avaliação Da Saúde Mental Em Profissionais E Estudantes Do Ensino Superior E Profissionais Do Ensino Básico Na Pandemia De Covid-19

Pesquisador Responsável: Leticia Oliveira, Mirtes Pereira e Marta Nudelman

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Departamento de Fisiologia e Farmacologia – UFF (Universidade Federal Fluminense)

Telefones para contato do Pesquisador: (21)

2629-2548 **Contato do pesquisador (e-mail):**

martanudelman@id.uff.br **Nome do Participante:** __

2) Convite

Você está sendo convidado(a) a participar da terceira etapa da pesquisa AVALIAÇÃO DA SAÚDE MENTAL EM PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONAIS

DO ENSINO BÁSICO NA PANDEMIA DE COVID-19. Antes de decidir se participará, é importante que você entenda o motivo do estudo que estar sendo feito e o que ele envolverá. Reserve um tempo para ler cuidadosamente as informações a seguir. Não tenha pressa de decidir se deseja ou não participar desta pesquisa.

3) O que é o projeto?

O projeto foi desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense em colaboração com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio de

Janeiro, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Universidade Federal de Ouro Preto, sob a coordenação das professoras Letícia de Oliveira e Mirtes Pereira Garcia. O objetivo é entender como você, profissional ou estudante, está lidando no momento com os desafios emocionais que surgem a partir da pandemia e as suas consequências ao longo do tempo, a partir do preenchimento de questionários online.

4) Qual é o objetivo do estudo?

Essa pesquisa foi elaborada com o intuito de entender melhor as possíveis consequências dessa pandemia relacionadas a saúde mental dos profissionais e estudantes e não tem a intenção de causar nenhum prejuízo.

5) Por que eu fui escolhido(a)?

O critério de inclusão para participação na pesquisa engloba ser maior de 18 anos, docente do ensino superior ou básico das redes públicas e/ou privadas, e/ou ser discente do ensino superior de rede pública e/ou privada ou ser técnico administrativo de faculdade ou Universidade. Lembrando que a participação é voluntária, conforme desejo e autorização dos interessados.

6) Eu tenho que participar?

Você é quem decide se gostaria de participar ou não deste estudo. Se decidir participar do projeto AVALIAÇÃO DA SAÚDE MENTAL EM PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONAIS DO ENSINO BÁSICO NA PANDEMIA DE COVID-19 você deverá

assinar este Registro e poderá imprimir uma via assinada pelo pesquisador, a qual você deverá guardar. Mesmo se você decidir participar, você ainda tem a liberdade de se retirar das atividades a qualquer momento, sem qualquer justificativa. Isso não afetará em nada sua participação em demais atividades e não causará nenhum prejuízo.

7) O que acontecerá comigo se eu participar? O que eu tenho que fazer?

- Confirmado sua participação, a próxima página dará acesso ao questionário online, no qual será pedido o preenchimento de todos os itens.
- Após o preenchimento deste questionário, você terá acesso a um breve texto com orientações para manter a saúde mental nesse momento.
- Além disso, por tratar-se de uma pesquisa que pretende investigar, ao longo do tempo, o impacto que a pandemia de COVID-19 pode estar causando e venha a causar na saúde mental das pessoas, ao final desta primeira etapa, você irá informar se deseja participar das próximas etapas. Se você concordar, será convidado por mais duas vezes, com a única finalidade de dar continuidade a esse estudo. Sua participação nas próximas etapas será opcional.

8) O que é exigido de mim nesse estudo?

O desejo em participar e o preenchimento de todos os itens dos questionários para que seja possível analisar os dados de maneira precisa, caso concorde em participar do experimento.

9) Eu terei alguma despesa ao participar da pesquisa?

Não haverá nenhum tipo de despesa em participar dessa pesquisa.

10) Quais são os eventuais riscos ao participar do estudo?

De acordo com as Resolução 466 e 510 do Conselho Nacional de Saúde, todas as pesquisas envolvem riscos, ainda que mínimos. Além disso, importante ressaltar que os questionários aqui apresentados investigarão eventos traumáticos vivenciados pelo indivíduo e poderão gerar um possível desconforto ou mal-estar durante o preenchimento. Isso poderá levar à lembrança de assuntos delicados e/ou eventos que causaram e/ou ainda causam sofrimento psíquico, além de sintomas físicos característicos de ansiedade. Outros sintomas como emoções negativas e irritabilidade também podem ser percebidos.

11) Quais são os possíveis benefícios de participar?

Essa investigação espera ampliar o entendimento a respeito da gravidade da vivência de eventos traumáticos em uma pandemia e pretende contribuir na elaboração de medidas concretas para proteção dos profissionais e estudantes durante uma pandemia. Como participante você estará contribuindo para o entendimento dos possíveis prejuízos de uma pandemia sobre a saúde mental e terá acesso a um breve texto com orientações para manter a saúde mental nesse momento.

12) O que acontece quando o estudo termina?

Os resultados desse estudo irão originar artigos, publicações em revistas, congressos e toda a produção e informativos serão disponibilizados no nosso site www.psicovida.org

13) E se algo der errado?

Caso sinta algum desconforto durante o preenchimento, você poderá solicitar ajuda através do nosso e-mail psicovida.uff@gmail.com ou através de nosso site (www.psicovida.org), onde você terá acesso ao contato de instituições que oferecem suporte psicológico online. Estaremos disponíveis através dos meios já mencionados caso você precise de apoio ou ajuda. Além disso, é importante enfatizar que a qualquer momento do preenchimento, você é livre para encerrar sua participação e minimizar qualquer tipo de desconforto.

Além dos possíveis riscos relacionados ao desconforto gerado por lembranças de assuntos que causaram e/ou ainda causam sofrimento psíquico, este estudo envolve

questionários que serão armazenados em um banco de dados digital online, em que existe um risco mínimo de acesso aos dados por hackers. Entretanto, o acesso será restrito aos pesquisadores, e assim que os formulários forem preenchidos serão retirados da “nuvem” e armazenados apenas em um computador físico dos pesquisadores responsáveis pela pesquisa, garantindo assim a privacidade e sigilo dos dados.

14) Minha participação neste estudo será mantida em sigilo?

Os dados obtidos com seu preenchimento serão usados apenas com objetivos científicos, não sendo possível a identificação individual. Tendo acesso apenas os pesquisadores responsáveis pela pesquisa, garantindo assim a privacidade e sigilo dos dados.

15) Contato para informações adicionais

Em caso de dúvidas, sugestões ou esclarecimentos, entre em contato conosco através dos e-mails psicovida.uff@gmail.com ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFF através do telefone +55 (21) 2629-9189 ou e-mail etica.ret@id.uff.br.

Caso prefira, entre em contato direto com nossa pesquisadora responsável: Marta Nudelman - martanudelman@id.uff.br

Rua Hernani Mello 101, Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UFF, Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento, sala 203 bloco Y. São Domingos, Niterói - Rio de Janeiro/ CEP: 24210-130

Telefones: 2629-2548

Dados do CEP:

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas:

E-mail: etica.ret@id.uff.br

Tel/fax: (21) 26299189

16) Remunerações financeiras

Nenhum incentivo ou recompensa financeira está previsto pela sua participação nesta pesquisa. Obrigado por ler estas informações. Se deseja participar deste estudo, assine este Registro de Consentimento Livre e Esclarecido e devolva-o ao(à) pesquisador(a). Você deve imprimir e guardar uma via deste documento para sua própria garantia.

1 – Confirmando que li e entendi as informações sobre o estudo acima e que tive a oportunidade de fazer perguntas.

2 – Entendo que minha participação é voluntária e que sou livre para retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar dar explicações, e sem sofrer prejuízo ou ter meus direitos afetados.

☐ Concordo com os termos acima.

☐ Não concordo com os termos acima.

9.3 Questionários de dados sociodemográficos

Por favor, responda às questões abaixo:

1. Por favor, insira seu email:

2. Você se encaixa em qual categoria:

☐ Docente do ensino superior

☐ Técnico Administrativo de ensino Superior e/ou pesquisa

☐ Discente de Graduação do Ensino Superior

☐ Discente de Pós-graduação

☐ Pesquisador de Pós-doutorado

☐ Docente do Ensino Básico

☐ Nenhuma das alternativas (encerrar questionário se marcar esta opção)

3. Você é menor de idade:

☐ Sim (encerra o questionário se marcar esta opção) ☐ Não

4. Quantos anos você tem? (apenas números):

5. Você se identifica com o gênero:

☐ Feminino;

☐ Masculino;

- ☐ Não-binário;
- ☐ Prefiro não declarar
- ☐ Outra opção

6. Você é uma pessoa trans:

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Prefiro não declarar

7. Raça: (obrigatório)

- ☐ Branca
- ☐ Parda
- ☐ Preta
- ☐ Amarela
- ☐ Indígena
- ☐ Não quero declarar

8. Em qual estado do Brasil você trabalha ou estuda?

- ☐ AC
- ☐ AL
- ☐ AM
- ☐ AP
- ☐ BA
- ☐ CE
- ☐ DF
- ☐ ES
- ☐ GO
- ☐ MA
- ☐ MG
- ☐ MS
- ☐ MT
- ☐ PA
- ☐ PB
- ☐ PE
- ☐ PI
- ☐ PR
- ☐ RJ
- ☐ RN
- ☐ RO

- ☐ RR
- ☐ RS
- ☐ SC
- ☐ SE
- ☐ SP
- ☐ TO

9. Qual(ais) o(s) nome(s) ou a sigla(s) da(s) sua(s) instituição(ões)?

10. Qual o tipo de instituição de ensino que você trabalha ou estuda?

- ☐ Público
- ☐ Particular
- ☐ Comunitária

11. Você teve alguma dessas patologias diagnosticadas por um psicólogo ou psiquiatra, antes do início da pandemia?

- ☐ Depressão
- ☐ Ansiedade generalizada
- ☐ Pânico
- ☐ Transtorno Bipolar
- ☐ Transtorno obsessivo-compulsivo
- ☐ Fobia
- ☐ Transtorno do Estresse Pós-traumático
- ☐ Burnout
- ☐ Outros transtornos (qual? _____)
- ☐ Não

9.4 Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9)

O instrumento PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9) é composto por nove questões, cujas respostas avaliam a frequência de sintomas depressivos. A escala de respostas variou de 0 (nenhum dia) a 3 (quase todos os dias). A nota de corte para classificação dos escores como elevados, assim indicativos de transtorno depressivo, foi definida em ≥ 9 .

Instruções: Por favor, leia cuidadosamente cada uma das afirmações abaixo e indique o número apropriado (0, 1, 2 ou 3) que indique o quanto ela se aplicou a você durante as duas últimas semanas, conforme a indicação a seguir: 0 - Nenhum dia 1 - Menos de 1 semana 2 - Uma semana ou mais 3 - Quase todos os dias				
Afirmativas	Escala de respostas			
	0	1	2	3
1. Teve pouco interesse ou pouco prazer em fazer as coisas?				
2. Sentiu-se para baixo, deprimido(a) ou sem perspectiva?				
3. Teve dificuldade para pegar no sono ou permanecer dormindo, ou dormiu mais do que de costume?				
4. Sentiu-se cansado(a) ou com pouca energia?				
5. Teve falta de apetite ou comeu demais?				
6. Sentiu mal consigo mesmo(a), ou achou que é um fracasso ou que decepcionou sua família ou a você mesmo(a)?				
7. Teve dificuldade para se concentrar nas coisas (como ler o jornal ou ver televisão)?				
8. Teve lentidão para se movimentar ou falar (a ponto das outras pessoas perceberem), ou esteve tão agitado(a) que ficava andando de um lado para o outro mais do que de costume?				
9. Pensou em se ferir de alguma maneira ou que seria melhor estar morto(a)?				

SANTOS, I. S. et al. Sensibilidade e especificidade do Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) entre adultos da população geral. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 29, n. 8, p. 1533–1543, 2013.

9.5 Confirmação de Submissão do artigo

Your manuscript has been opted in to In Review

External

Caixa de entrada x



In Review at International Journal for Equity in Health <noreply@springernature.com>

para mim ▾

ter., 11 de nov., 15:53 (há 7 dias)



Dear Dr. Leticia Oliveira,

Your manuscript "Black Women: The Intersection of Race and Gender as a Source of Mental Health Vulnerability in Academia" has been opted in to [In Review](#) from Springer Nature as part of its submission to International Journal for Equity in Health. *In Review* is a free preprint service that permanently posts your manuscript to the preprint server [Research Square](#).

The *In Review* service will:

- Publicly share your manuscript on Research Square in the form of a preprint with a DOI.
- Allow the public to track the status of your manuscript through the peer review process using a peer review timeline.
- Enable you the benefits of early sharing, such as more collaboration opportunities and earlier citations.
- Provide an opportunity to receive feedback and comments from the community that can improve your manuscript.

All preprints posted as part of the *In Review* service are screened for preprint suitability, formatted, assigned a DOI, and publicly posted under a CC-BY 4.0 license as a preprint on Research Square. It will be permanently available for anyone to view online, regardless of the journal decision.

If you have any questions about why your manuscript was opted in to *In Review*, please contact the submitting author. If the preprint has not yet been posted, the submitting author will be able to opt out by logging in to their Research Square Dashboard. Once the preprint is posted, you will no longer be able to opt out of *In Review*.

9.6 Declaração de uso de Inteligência Artificial

Universidade Federal Fluminense

Instituto Biomédico

Programa de pós-graduação em Ciências Biomédicas

Fisiologia e Farmacologia

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) NA ESCRITA DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO E DISSERTAÇÕES

Título da dissertação: Mulheres negras: intersecção de raça e gênero como fator de vulnerabilidade
na saúde mental da comunidade acadêmica

Estudante: Rony Magalhães Martins

Orientador(es): Profª Drª Letícia de Oliveira e Profª Drª Mirtes Garcia Pereira

Eu, autor da dissertação acima mencionada, declaro que ferramenta(s) de Inteligência Artificial (IA) foi/foram utilizada(s) no processo de elaboração da **Dissertação de mestrado - Mulheres negras: intersecção de raça e gênero como fator de vulnerabilidade na saúde mental da comunidade acadêmica**. Em conformidade com as políticas de transparência e integridade acadêmica, forneço os seguintes detalhes:

1. Ferramenta(s) de IA utilizada(s):

o Nome da ferramenta: DeepSeek; ChatGPT

o Versão: Versão de Janeiro de 2026

o Desenvolvedor: DeepSeek-AI; OpenAI

2. Finalidade do uso:

o Auxílio na revisão gramatical

o Criação de e-mails e convites relacionados ao projeto

o Organização da lista de referências

3. Extensão do uso:

o Porcentagem estimada do conteúdo gerado ou modificado pela IA: 15%

o Seções específicas onde a IA foi utilizada: Introdução, discussão e referências

4. Processo de verificação: Confirmo que a contribuição intelectual humana é predominante, de que toda alteração sugerida por IA foi conferida por um humano, e que a integridade científica e originalidade do trabalho foi mantida.

Data: 21/03/2026